



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**PANDUAN PENGGUNAAN ANTIBIOTIK
RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
MALANG
TAHUN 2025**

Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada
Nomor 571.88/I-PND/DIR/VI/2025

Tentang
Panduan Penggunaan Antibiotik Rumah Sakit Prima Husada Malang Tahun 2025

Disusun oleh:
Ketua PPRA



(dr. Dicky Faturrachman, Sp. A., Biomed)

Disetujui oleh :
Authorized Person :



(Dr. dr. Aslichah, M.Kes. AFP)

Ditetapkan oleh :
PLT Direktur Rumah Sakit Prima Husada



(dr. Resti Lestantini, M.Kes)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat-Nya, Panduan Penggunaan Antibiotik Rumah Sakit Prima Husada Malang Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan kebutuhan Rumah Sakit Prima Husada.

Panduan Penggunaan Antibiotik tahun 2025 ini mulai dipergunakan pada tahun 2025 meliputi aturan pemberian antibiotik terapi maupun profilaksis yang ada di Rumah Sakit Prima Husada.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun yang telah berjuang untuk menyelesaikan Panduan ini dengan baik. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada para kontributor yang telah memberikan masukan dengan baik.

Semoga dengan dipergunakan Panduan Penggunaan Antibiotik Tahun 2025 ini, mutu pelayanan dan keselamatan di rumah sakit Prima Husada utamanya dalam pemberian antibiotik guna mencegah terjadinya resistensi dapat berjalan lebih baik.

Malang, 23 Desember 2025
Direktur Rumah Sakit Prima Husada



dr. Resti Lestantini, M.Kes

TIM PENYUSUN

1. dr. Dicky Faturrachman, Sp. A., M. Biomed.
2. apt. Rifdah Bunga Kwintana, S.Farm
3. dr. Ari Putriani, Sp. PK
4. dr. Arief Heru Wicaksono, Sp. An
5. dr. Ardhi Bustami, Sp. PD
6. dr. Adhya Aji Pratama, Sp. PD
7. dr. Antonius Setiadi, Sp. B
8. dr. Iwan Donosepoetro, Sp. B.FINACS
9. dr. Sigit Wahyu Jatmiko, Sp. BP-RE
10. dr. Heriyatmo, Sp. PD
11. dr. Ira Setya, Sp. JP
12. dr. Dewi Maharani, Sp. S
13. dr. Titok Hariyanto, Sp. M
14. dr. Aida Musyarrofah, Sp. OG
15. dr. Andy, Sp. P
16. dr. Pradana Nurhadi, Sp. U
17. dr. Arianto, Sp. OT
18. dr. Nimim Putri Zahra, Sp. THT-KL
19. dr. Miftakhul Huda, Sp. KJ
20. drg. Bhakti Prasetyo D, Sp. Ort.
21. dr. Dwi Nurwulan Pravita., Sp. KK
22. dr. Naufal Fraid Dwi Rendragraha
23. dr. Rino Rachmatullah
24. Putri Indah Purnamasari, A.Md. Keb
25. apt. Yuanita Eka L, S.Farm
26. apt. Asharul Fahrizi, S.Farm
27. apt. Guspa Gayatri Azmi, S. Farm
28. apt. Fadilah Maulana Irham Ashari, S. Farm
29. ns. Very Susanto, S.Kep
30. ns. Siti Durotul Ibadiyah, S. Kep
31. Puput Sekar Nari Ratih, AMd. Keb
32. Sherly Rosita, Amd. Kep
33. Trikaya Inggar Yuniar, AMd. Kep

DAFTAR ISI

Halaman Judul..... 1

KATA PENGANTAR..... 3

TIM PENYUSUN 4

DAFTAR ISI 5

DAFTAR TABEL..... 7

BAB I. PENDAHULUAN 11

1.1 Latar Belakang 11

1.2 Maksud dan Tujuan..... 11

1.2.1 Maksud 11

1.2.2 Tujuan Umum..... 11

1.3 Pengertian 11

BAB II. RUANG LINGKUP 13

BAB III. TATA LAKSANA 14

3.1 SMF BEDAH..... 14

3.2 SMF Mata 24

3.3 SMF Obstetri Ginekologi 27

3.3.1 Profilaksis Bedah Obstetri Ginekologi 27

3.3.2 Infeksi Obstetri Ginekologi..... 27

3.4. SMF Anak 29

3.4.1 Divisi Infeksi dan Penyakit Tropik (Parasit)..... 29

3.4.2 Divisi Infeksi dan Penyakit Tropik (Bakteri)..... 30

3.4.3 Divisi Infeksi dan Penyakit Tropik (Jamur)..... 31

3.4.4 Divisi Infeksi dan Penyakit Tropik (Virus)..... 32

3.4.5 Divisi Gastrohepatologi 33

3.4.6 Divisi Respirologi..... 33

3.4.7 Divisi Neurologi..... 35

3.4.8 Divisi Neonatal..... 36

3.4.9 Divisi PGD..... 38

3.4.10 Divisi Kardiologi 40

3.4.11 Divisi Nefrologi 41

3.4.12 Divisi Nutrisi..... 41

3.5 INTENSIVE CARE UNIT (ICU)..... 42

3.6 INTENSIVE CARE UNIT (ICU) COVID-19 / IPIT 44

3.7 SMF ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF 46

3.8 SMF PARU 47

3.9 SMF Neurologi..... 53

3.11 SMFJANTUNG 56

3.12 SMF KULIT dan KELAMIN 57

3.13 SMF Ilmu Penyakit Dalam 67

BAB IV. PENUTUP.....	72
BAB V CARA PENGGUNAAN ANTIMIKROBA.....	73
BAB VI CATATAN KHUSUS.....	73

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Panduan Antibiotik 14

Tabel 2 Rekonstitusi Antibiotik 73

Tabel 3 Daftar Keamanan Obat Antimikroba Pada Kehamilan 80

Tabel 4 Penyesuaian Dosis Pada Gangguan Ginjal 82

Tabel 5 Saat Pemberian Antibiotik..... 85

**PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
NOMOR 571.88/I-PND/DIR/VI/2025**

**TENTANG
PANDUAN PENGGUNAAN ANTIBIOTIK TAHUN 2025**

DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan mutu pelayanan rumah sakit, diperlukan adanya kebijakan mengenai penggunaan antibiotik yaitu panduan penggunaan antibiotik
- b. bahwa diperlukan pembaruan panduan penggunaan antibiotik sesuai dengan peraturan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Direktur tentang Panduan Penggunaan Antibiotik tahun 2025
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2015 tentang Program Pengendalian Resistensi Antimikroba di Rumah Sakit;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 03 tahun 2020 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 Pedoman Penggunaan Antibiotik;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1596/2024 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit;
8. Keputusan Direktur Jendral Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/D/47104/2024 tentang Instrumen Survei Akreditasi Rumah Sakit;
9. Keputusan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor 390/I-KEP/DIR/V/2023 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Prima Husada;
10. Keputusan Direktur Utama Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor : 104.92/DPM/I-KEP/DIR/IX/2025 tentang Pengangkatan PLT Direktur Rumah Sakit Prima Husada Malang;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
TENTANG PANDUAN PENGGUNAAN ANTIBIOTIK**

Pasal 1

Panduan Penggunaan Antibiotik sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama sebagaimana terlampir dalam peraturan ini.

Pasal 2

Panduan Penggunaan Antibiotik digunakan sebagai acuan dalam pemberian antibiotik kepada pasien dan sebagai evaluasi pemberian antibiotik di Rumah Sakit Prima Husada.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada tentang Panduan Penggunaan Antibiotik nomor 783.91/I/PND/DIR/VI/2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang,

Pada tanggal 23 Desember 2025

PLT Direktur Rumah Sakit Prima Husada,



dr. Resti Lestantini, M. Kes

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH
SAKIT PRIMA HUSADA
NOMOR : 571.88/I-PND/DIR/VI/2025
TENTANG
PANDUAN PENGGUNAAN ANTIBIOTIK
TAHUN 2025

PANDUAN PENGGUNAAN ANTIBIOTIK TAHUN 2025

BAB I.
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Antibiotik merupakan golongan obat yang banyak digunakan untuk infeksi bakteri dan intervensi medis lain. Penggunaan antibiotik di dunia pada tahun 2000 - 2010 mengalami peningkatan hingga 36 %. Jumlah penggunaan antibiotik yang relatif tinggi menyebabkan munculnya berbagai permasalahan dan menjadi ancaman bagi kesehatan terutama terjadinya risiko resistensi antibiotik. Bakteri yang telah resisten terhadap antibiotik akan memperpanjang waktu rawat inap pasien, perlunya kunjungan dokter dan perawatan kesehatan tambahan, meningkatkan risiko kecacatan dan kematian, serta meningkatkan biaya terapi.

Resistensi antibiotik di Indonesia mengalami peningkatan khususnya untuk bakteri *S. pneumoniae*, *S. aureus*, dan *E. coli*. Di Indonesia bakteri penghasil *Extended spectrum beta-lactamases* (ESBL) tertinggi yaitu pada bakteri *E. coli* sebesar 71 % dan pada *Klebsiella* sebesar 64 % dibandingkan dengan 12 negara Asia Pasifik lain. Penelitian yang dilakukan di Kota Semarang menunjukkan bahwa bakteri *S. pneumoniae* resisten terhadap antibiotik kotrimoksazol sebesar 45 % dengan tingkat sensitivitas terhadap non-penisilin sebesar 24 %. Isolat *E. coli* pada penelitian tersebut juga mengalami resistensi terhadap beberapa antibiotik yaitu ampisilin (73 %), kotrimoksazol (56 %), dan siprofloksasin (22 %).

Panduan penggunaan antibiotik ditujukan untuk menekan pemberian antibiotik yang tinggi serta tidak rasional sehingga dapat menekan angka resistensi bakteri terhadap antibiotik. Panduan penggunaan antibiotik perlu dilakukan pembaruan sesuai dengan Panduan Penggunaan Antibiotik Nasional terbaru, buku referensi kedokteran, dan peta kuman yang ada.

1.2 Maksud dan Tujuan

1.2.1 Maksud

Maksud dari panduan penggunaan antibiotik ini adalah sebagai acuan pengendalian penggunaan antibiotik dan sebagai evaluasi pemberian antibiotik di Rumah Sakit Prima Husada Malang.

1.2.2 Tujuan Umum

Salah satu bagian dari dokumentasi proses pengorganisasian Rumah Sakit Prima Husada sebagai bahan evaluasi proses pengorganisasian kedepannya.

1.3 Pengertian

- Antibiotik adalah segolongan molekul, baik alami maupun sintetik yang mempunyai efek menekan maupun menghentikan suatu proses biokimia di dalam organisme, khususnya dalam proses infeksi oleh bakteri
- Resistensi antimikroba adalah kemampuan mikroba untuk bertahan hidup terhadap efek antimikroba sehingga tidak efektif dalam penggunaan klinis
- Pengendalian resistensi antimikroba adalah aktivitas yang ditujukan untuk mencegah

dan atau menurunkan adanya kejadian mikroba resisten

- d. Komite Program Pengendali Resistensi Antimikroba adalah panitia/ tim yang dibentuk oleh direktur Rumah Sakit dalam rangka mengendalikan penggunaan antimikroba secara luas baik di fasilitas pelayanan kesehatan dan di masyarakat
- e. Panduan Program Pengendali Resistensi Antibiotik bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan mengurangi terjadinya resistensi terhadap obat-obatan golongan antibiotik, melaksanakan penggunaan antibiotik secara bijak, sebagai panduan penggunaan antibiotik, serta melaksanakan prinsip pencegahan pengendalian infeksi

BAB II. RUANG LINGKUP

Panduan Penggunaan Antibiotik memuat informasi dan pedoman umum mengenai penggunaan antibiotik yang dapat digunakan bagi para pimpinan rumah sakit sebagai kebijakan pemberian antibiotik di Rumah Sakit. Panduan Penggunaan Antibiotik juga dapat digunakan sebagai dasar acuan dalam evaluasi penggunaan antibiotik secara kualitatif.

BAB III. TATA LAKSANA

3.1 SMF BEDAH

3.1.1 Divisi Bedah Digestif

Tabel 1 Panduan Antibiotik

No	Keadaan klinik/penyakit/tindakan	Rekomendasi antimikroba	Dosis		Empiris/ profilaksis	Interval	Lama pemberian	Keterangan
			Dewasa	Anak				
1.	Seluruh Operasi Digestif dengan Indikasi Peritonitis dan Abses	Ciprofloxacin + Metronidazole	IV : 400 mg + IVFD : 500 mg	-	EMPIRIS	12 jam + 8 jam	7 hari	
2.	Bersih Terkontaminasi : Gastroduodenal	Cefazoline	IV : 2 gram	IV : 15-20 mg/kg	PROFILAKSIS	24 jam	1 hari	
		Gentamycin	IV : 5 mg/kg	IV : 2,5 mg/kg	PROFILAKSIS	24 jam	1 hari	Bila alergi cefazolin
3.	Bersih Terkontaminasi : Kolorektal elektif	Cefazoline	IV : 2 gram	IV : 15-20 mg/kg	PROFILAKSIS	24 jam	1 hari	
		Gentamycin	IV : 5 mg/kg	IV : 2,5 mg/kg	PROFILAKSIS	24 jam	1 hari	Bila alergi cefazolin
4.	Appendektomi	Cefazoline	IV : 2 gram	IV : 15-20 mg/kg	PROFILAKSIS	24 jam	1 hari	
		Gentamycin	IV : 5 mg/kg	IV : 2,5 mg/kg	PROFILAKSIS	24 jam	1 hari	Bila alergi cefazolin

3.1.2 Divisi Bedah Plastik dan Rekonstruksi

No	Keadaan klinik/penyakit/tindakan	Rekomendasi antimikroba	Dosis		Empiris/ profilaksis	Interval	Lama pemberian	Keterangan
			Dewasa	Anak				
1.	Pengguna Antimikroba pada Infeksi Kulit dan Jaringan Lunak	Cloxacillin	IV : 250 – 500 mg	IV : 100 – 200 mg/kg/hari	EMPIRIS	6 jam	3 - 7 hari (Sampai didapatkan hasil kultur)	Kultur diambil sebelum diberikan antibiotik empiris
2.	Bersih Kraniomaksilofasial : Operasi bersih terkontaminasi pada kulit dan jaringan lunak wajah	Cefazoline	IV : 2 gram	IV : 15-20 mg/kg	PROFILAKSIS	24 jam	1 hari	
		Gentamycin	IV : 5 mg/kg	IV : 2,5 mg/kg	PROFILAKSIS	24 jam		Bila alergi cefazolin
3.	Bersih Kraniomaksilofasial : Operasi terkontaminasi pada kulit dan jaringan lunak wajah	Cefazoline	IV : 2 gram	IV : 15-20 mg/kg	PROFILAKSIS	24 jam	1 hari	Dapat dilanjutkan 3x24 jam dengan acc PIC bedah
		Gentamycin	IV : 5 mg/kg	IV : 2,5 mg/kg	PROFILAKSIS	24 jam		Bila alergi cefazolin

4.	Bedah Kraniomaksilofasial : Operasi terkontaminas fraktur tulang wajah	Cefazoline	IV : 2 gram	IV : 15-20 mg/kg	PROFILAKSIS	24 jam	1 hari	Dapat dilanjutkan 3x24 jam dengan acc PIC bedah
		Gentamycin	IV : 5 mg/kg	IV : 2,5 mg/kg	PROFILAKSIS	24 jam		Bila alergi cefazolin
5.	Bedah Kulit dan Luka Bakar : Operasi bersih Skin Grafting dan Flap kulit	Cefazoline	IV : 2 gram	IV : 15-20 mg/kg	PROFILAKSIS	24 jam	1 hari	Dapat dilanjutkan 3x24 jam dengan acc PIC bedah
		Gentamycin	IV : 5 mg/kg	IV : 2,5 mg/kg	PROFILAKSIS	24 jam		Bila alergi cefazolin
6.	Bedah Kulit dan Luka Bakar : Operasi bersih dan terkontaminasi Debridement luka bakar akut, prosedur substitusi kulit dan rekontruksi defek luka	Cefazoline	IV : 2 gram	IV : 15-20 mg/kg	PROFILAKSIS	24 jam	1 hari	Dapat dilanjutkan 3x24 jam dengan acc PIC bedah
		Gentamycin	IV : 5 mg/kg	IV : 2,5 mg/kg	PROFILAKSIS	24 jam		Bila alergi cefazolin
7.	Bedah Tangan dan Bedah Mikro : Operasi bersih Skin Grafting dan Flap, implant pada prosedur rekontruksi jari dan tangan	Cefazoline	IV : 2 gram	IV : 15-20 mg/kg	PROFILAKSIS	24 jam	1 hari	Dapat dilanjutkan 3x24 jam dengan acc PIC bedah
		Gentamycin	IV : 5 mg/kg	IV : 2,5 mg/kg	PROFILAKSIS	24 jam		Bila alergi cefazolin
8.	Bedah Tangan dan Bedah Mikro : Operasi terkontaminasi Debridement fraktur terbuka jari, degloving dengan pengotoran luas	Cefazoline	IV : 2 gram	IV : 15-20 mg/kg	PROFILAKSIS	24 jam	1 hari	Dapat dilanjutkan 3x24 jam dengan acc PIC bedah
		Gentamycin	IV : 5 mg/kg	IV : 2,5 mg/kg	PROFILAKSIS	24 jam		Bila alergi cefazolin
9.	Penggunaan AB topikal pada perawatan luka bakar	Salep mata Gentamycin/ Chloramphenicol	Topikal	Topikal	EMPIRIS	24 jam	7 hari	Pasca operasi area wajah

3. 1.3 Divisi Bedah Orthopedi dan Traumatologi

No	Keadaan klinik/penyakit/tindakan	Rekomendasi antimikroba	Dosis		Empiris/ profilaksis	Interval	Lama pemberian	Keterangan
			Dewasa	Anak				
1.	Operasi Besih : Skin garfting, flap, rekonstruksi tendon dan neuro vaskuler	Cefazoline	IV : 2 gram	IV : 15-20 mg/kg	PROFILAKSIS	24 jam	1 hari	
		Gentamycin	IV : 5 mg/kg	IV : 2,5 mg/kg	PROFILAKSIS	24 jam	1 hari	Bila alergi cefazolin
2.	Patah tulang terbuka grade I, II kurang dari 6 jam	Cefazoline	IV : 2 gram	IV : 15-20 mg/kg	PROFILAKSIS	24 jam	1 hari	Dapat dilanjutkan 3x24 jam dengan acc PIC bedah

		Gentamycin	IV : 5 mg/kg	IV : 2,5 mg/kg	PROFILAKSIS	24 jam	1 hari	Bila alergi cefazolin
3.	Patah tulang terbuka grade I, II, III lebih dari 6 jam	Ampicillin - Sulbactam + Gentamycin		IV : 15-20 mg/kg IV : 2,5 mg/kg IV	EMPIRIS	8 jam 24 jam	3 hari	Kultur diambil sebelum diberikan antibiotik empiris
4.	Luka terbuka soft tissue injury otot tendon neurovascular < 6 jam	Cefazoline	IV : 2 gram	IV : 15-20 mg/kg	PROFILAKSIS	8 jam 24 jam	1 hari	Kultur diambil sebelum diberikan antibiotik empiris. Pemberian antibiotik secara extended 3x24 jam harus dengan ACC KPRA
5.	Luka terbuka soft tissue injury otot tendon neurovascular > 6 jam	Ampicillin - Sulbactam	IV : 1500 mg IV : 5 mg/kg	IV : 15-20 mg/kg IV : 2,5 mg/kg IV	EMPIRIS	8 jam 24 jam	3 hari	Kultur diambil sebelum diberikan antibiotik empiris
6.	Sepsis dengan patah tulang terbuka	Cloxacillin	IV : 1000 mg	IV : 100-200 mg/kg/hari	EMPIRIS	6 jam	7 hari	Bila Cloxacillin tidak tersedia maka dapat menggunakan Ampicillin 4x1000 mg
		Ampicillin - Sulbactam	IV : 1500 mg	IV : 15-20 mg/kg/hari	EMPIRIS	6 jam	7 hari/klinis/ sampai didapatkan hasil kultur	Kultur diambil sebelum diberikan antibiotika empiris dari luka dan darah
7.	Osteomyelitis dan septic arthritis	Cloxacillin	IV : 1000 mg	IV : 100-200 mg/kg/hari	EMPIRIS	6 jam	7 hari/klinis/ sampai didapatkan hasil kultur	Bila Cloxacillin tidak tersedia maka dapat menggunakan Ampicillin Sulbactam. Kultur diambil sebelum diberikan antibiotika empiris. Untuk osteomyelitis TB Konsul dengan PIC
8.	Diabetic Foot	Ampicillin - Sulbactam	IV : 1500 mg		EMPIRIS	6 jam	7 hari/klinis/ sampai didapatkan hasil kultur	Kultur diambil sebelum diberikan antibiotika empiris

3.1.4 Divisi Bedah Urologi

No	Keadaan klinik/penyakit/tindakan		Dosis		Interval		Keterangan
----	----------------------------------	--	-------	--	----------	--	------------

		Rekomendasi antimikroba	Dewasa	Anak	Empiris/ profilaksis		Lama pemberian	
1.	Operasi Bersih : Nefropeksi / Hidrokel / Palomo prosedur / torsiotestis UDT / Parapimhosis / Fimosis / koreksi priapismus / Hipospadia	Tidak perlu Antibiotik	-	-	-	-	-	-
2.	Operasi Bersih Terkontaminasi : Batu Ginjal, Batu Ureter, batu buli	Gentamycin	IV : 80 mg	IV : 15-20 mg/kg	PROFILAKSIS	24 jam	1 hari	Bila Ur Cr tinggi diberikan Cefoperazone
3.	Endoskopi (Operasi Bersih Terkontaminasi dan Terkontaminasi), Percutaneous Nephrolithotomy, Ureteroscopic Lithotripsy, ESWL Transurethral Resection of the prostate Litotripsy, Sistocopi/AffDJ Stent Uretrotomi interna	Gentamycin	IV : 80 mg	IV : 15-20 mg/kg	PROFILAKSIS	24 jam	1 hari	Bila Ur Cr tinggi diberikan Cefoperazone
4.	Tindakan Diagnostik Bersih Terkontaminasi dan Terkontaminasi : Biopsi Prostat Sistografi	Gentamycin	IV : 80 mg	IV : 15-20 mg/kg	PROFILAKSIS	24 jam	1 hari	Bila Ur Cr tinggi diberikan Cefoperazone
5.	Operasi Terkontaminasi : Abses dll	Ciprofloxacin	IVFD : 400 mg		EMPIRIS	12 jam	7 hari	
		Metronidazole	IVFD : 500 mg		EMPIRIS	8 jam	7 hari	

3.1.5 Divisi Bedah Syaraf

No	Keadaan klinik/penyakit/tindakan	Rekomendasi antimikroba	Dosis		Empiris/ profilaksis	Interval	Lama pemberian	Keterangan
			Dewasa	Anak				
1.	Fraktur Dasar Tengkorak Anak dan Dewasa	Ceftriaxone	IV : 1 gram		PROFILAKSIS	12 jam	1 hari	Pemberian antibiotik secara berkepanjangan 7x24 jam harus dengan ACC KPRA
2.	Operasi Tanpa Buka Dura	Ceftriaxone	IV : 1 gram	IV : 15-20 mg/kg	PROFILAKSIS	24 jam	1 hari	Untuk operasi yang berkepanjangan dosis ditambah satu atau lebih menurut lama operasi sampai lepas drain atau 24 jam bila tanpa drain harus dengan ACC KPRA

3.	Operasi Bersih Operasi Dengan Buka Dura	Ceftriaxone	IV : 1 gram		PROFILAKSIS	24 jam	1 hari	Lama pemberian sampai lepas drain atau 24 jam bila tanpa drain max 7 hari harus dengan ACC KPRA
4.	Operasi Bersih Terkontaminasi OP + Leakage csf	Ceftriaxone	IV : 1 gram		PROFILAKSIS	12 jam	1 hari	Sampai leakage csf berhenti dan lepas drain. Pemberian antibiotik secara extended harus dengan ACC KPRA

3.1.6 Divisi Telinga, Hidung, Tenggorokan dan Kepala Leher

No	Keadaan klinik/penyakit/tindakan	Rekomendasi antimikroba	Dosis		Empiris/ profilaksis	Interval	Lama pemberian	Keterangan
			Dewasa	Anak				
1.	Rhinosinusitis Akut (bakterial)	Ciprofloxacin	PO : 500 mg		EMPIRIS	12 jam	5 hari	Kultur diambil di hari ke 5
		Cotrimoxazole	PO : 960 mg		EMPIRIS	12 jam	5 hari	Kultur diambil di hari ke 5
		Amoxicillin- Clavulanic Acid	PO : 625 mg	PO : 20 mg/kg/hari	EMPIRIS	8 jam	5 hari	Kultur diambil di hari ke 5. Hanya untuk anak
2.	Rhinosinusitis Kronik	Ciprofloxacin	PO : 500 mg		EMPIRIS	12 jam	5 hari	Kultur diambil di hari ke 5
		Cotrimoxazole	PO : 960 mg		EMPIRIS	12 jam	5 hari	Kultur diambil di hari ke 5
		Amoxicillin- Clavulanic Acid	PO : 625 mg	PO : 20 mg/kg/hari	EMPIRIS	8 jam	5 hari	Kultur diambil di hari ke 5. Hanya untuk anak
3.	Rhinosinusitis Kronik dengan Komplikasi	Amoxicillin- Clavulanic Acid	PO : 625 mg	PO : 20 mg/kg/hari	EMPIRIS	8 jam	5 hari	Kultur diambil di hari ke 5. Hanya untuk anak
		Amikacin	IV : 15 mg/kg/hari		EMPIRIS	8-12 jam	5 hari	Kultur diambil di hari ke 5
		Cotrimoxazole	PO : 960 mg	PO : 6-10 mg/TMP/kg/hari	EMPIRIS	12 jam	5 hari	Kultur diambil di hari ke 5. Hanya untuk anak
4.	Rhinitis Ozeana	Ciprofloxacin	PO : 500 mg	PO : 10-20 mg/kg	EMPIRIS	12 jam	5 hari	
		Gentamycin	IV : 3-5 mg/kg/hari	IV : 7,5 mg/kg/hari	EMPIRIS	24 jam	5 hari	
5.	Otitis Media Supuratif Akut	Ciprofloxacin	PO : 500 mg	PO : 10-20 mg/kg	EMPIRIS	12 jam	5 hari	
		Amoxicillin- Clavulanic Acid	PO : 625 mg	PO : 20 mg/kg/hari	EMPIRIS	8 jam	5 hari	

6.	Otitis Media Supuratif Kronik tanpa Kolesteatoma	Amoxicillin-Clavulanic Acid	PO : 625 mg	PO : 20 mg/kg/hari	EMPIRIS	8 jam	5 hari	
		Ciprofloxacin	PO : 500 mg	PO : 10-20 mg/kg	EMPIRIS	12 jam	5 hari	
7.	Abses Retroaurikula	Amoxicillin-Clavulanic Acid	PO : 625 mg	PO : 20 mg/kg/hari	EMPIRIS	8 jam	5 hari	
		Ciprofloxacin	PO : 500 mg	PO : 10-20 mg/kg	EMPIRIS	12 jam	5 hari	
8.	Otitis Eksterna Maligna	Amoxicillin-Clavulanic Acid	PO : 625 mg	PO : 20 mg/kg/hari	EMPIRIS	8 jam	5 hari	
9.	Perichondritis	Ciprofloxacin	IV: 200 mg	PO : 10-20 mg/kg	EMPIRIS	12 jam	5 hari	
		Levofloxacin	IVFD : 500 mg	IVFD : 8mg/kg	EMPIRIS	24 jam	5 hari	Bila tidak membaik menggunakan ciprofloxacin
10.	Sialadenitis	Amoxicillin-Clavulanic Acid	PO : 625 mg	PO : 20 mg/kg/hari	EMPIRIS	8 jam	5 hari	
11.	Tonsilitis Akut	Amoxicillin-Clavulanic Acid	PO : 625 mg	PO : 20 mg/kg/hari	EMPIRIS	8 jam	5 hari	
12.	Faringitis Akut	Amoxicillin-Clavulanic Acid	PO : 625 mg		EMPIRIS	8 jam	5 hari	
		Amoxicillin		PO : 25 mg/kg/hari	EMPIRIS	12 jam	5 hari	
		Cefadroxile	PO : 500 mg	PO : 30 mg/kg/hari	EMPIRIS	12 jam	5 hari	
13.	Epiglottitis Akut	Amoxicillin-Clavulanic Acid	PO : 625 mg	PO : 20 mg/kg/hari	EMPIRIS	8 jam	5 hari	
		Cefadroxile	PO : 500 mg	PO : 30 mg/kg/hari	EMPIRIS	12 jam	5 hari	
14.	Laringitis Akut	Amoxicillin-Clavulanic Acid	PO : 625 mg	PO : 20 mg/kg/hari	EMPIRIS	8 jam	5 hari	
		Cefadroxile	PO : 500 mg	PO : 30 mg/kg/hari	EMPIRIS	12 jam	5 hari	
15.	Laringotrakeobronkitis	Ciprofloxacin + Metronidazol	IV : 200 mg IV : 500 mg	PO : 10-20 mg/kg IV : 30 mg/kg/hari	EMPIRIS	12 jam 8 jam	5 hari	
16.	Peritonsil Abses	Ciprofloxacin + Metronidazol	IV : 200 mg IV : 500 mg	PO : 10-20 mg/kg IV : 30 mg/kg/hari	EMPIRIS	12 jam 8 jam	5 hari	
17.	Operasi bersih terkontaminasi di daerah Telinga, Hidung, Tenggorok, Esofagus, dan Bronkus	Cefazolin	IV : 1 gram		PROFILAKSIS	8 jam	1 hari	

18.	Otitis Externa	Ofloxacin	Tetes : 3-4x3 tetes	Tetes : 3-4 x 3 tetes	EMPIRIS	6-8 jam	5 hari	Tetes telinga
-----	----------------	-----------	---------------------	-----------------------	---------	---------	--------	---------------

3. 1.7 Divisi Bedah Anak

No	Keadaan klinik/penyakit/tindakan	Rekomendasi antimikroba	Dosis		Empiris/ profilaksis	Interval	Lama pemberian	Keterangan
			Dewasa	Anak				
1.	Appendectomy (tanpa perforasi)	Cefazoline	-	50 mg/kgBB (max 2 gr)	PROFILAKSIS	Diulang tiap 3 jam dgn dosis 30 mg / kg BB	1 hari	Dapat dilanjutkan 1x24 jam post operatif dgn dosis 30 mg/kgBB selama 3 x pemberian (dengan acc PIC KPRA)
2.	Appendectomy (dengan perforasi)	Cefotaxime / Cefoperazone Sulbactam + Metronidazole	-	50-180 mg/kgBB/hari 50mg/kgBB/hari + 10 mg/kgBB/X	EMPIRIS	Dibagi dalam 2-4 dosis + Tiap 8 jam	7 hari	
3.	Tutup stoma (large/small bowel)	Cefazoline + Metronidazole	-	50 mg/kgBB + 15 mg/kgBB	PROFILAKSIS	Diulang tiap 3 jam (dosis 30 mg/kgBB) + Diulang tiap 3 jam (dosis 7.5 mg/kgBB)	1 hari	Dapat dilanjutkan 1x24 jam post operatif dengan dosis Cefazoline 30 mg/kgBB selama 3x pemberian dan dosis Metronidazole 7,5 mg/kgBB selama 3x pemberian (dengan acc PIC KPRA)
4.	Eksisi tumor (intra abdomen)	Cefazoline	-	50 mg/kgBB (max 2 gr)	PROFILAKSIS	Diulang tiap 3 jam dgn dosis 30 mg/kgBB	1 hari	Dapat dilanjutkan 1x24 jam post operatif dgn dosis 30 mg/kgBB selama 3 x pemberian (dengan acc PIC KPRA)
5.	Operasi intra abdomen lain dengan indikasi peritonitis atau ileus obstruksi	Cefotaxime + Metronidazole	-	50-180 mg/kgBB/hari + 10 mg/kgBB/x	EMPIRIS	Dibagi dalam 2-4 dosis + Tiap 8 jam	7 hari	

6.	Eksisi tumor kulit (< 3 cm)	Tanpa Antibiotik	-	-	-	-	-	-
7.	Abses subkutan	Ampicillin Sulbactam	-	Infeksi ringan sedang : 25 - 50mg/kgBB	Terapeutik	Tiap 6 jam (max 4 gram / hari)	< 14 hari	-
8.	Koreksi hernia (inguinal, umbilical)	Tanpa Antibiotik	-	-	-	-	-	-
9.	Koreksi hydrocele	Tanpa Antibiotik	-	-	-	-	-	-
10.	Sirkumsisi	Tanpa Antibiotik	-	-	-	-	-	-
11.	Koreksi hypospadia	Cefazoline	-	50 mg/kgBB	PROFILAKSIS	Diulang tiap 3 jam dgn dosis 30 mg/kgBB	1 hari	Dapat dilanjutkan 1x24 jam post operatif dgn dosis 30 mg/kgBB selama 3 x pemberian (dengan acc PIC KPRA)
12.	Koreksi buried penis, webbed penis	Cefazoline	-	50 mg/kgBB	PROFILAKSIS	Diulang tiap 3 jam dgn dosis 30 mg/kgBB	1 hari	Dapat dilanjutkan 1x24 jam post operatif dgn dosis 30 mg/kgBB selama 3 x pemberian (dengan acc PIC KPRA)
13.	Koreksi hernia insisional	Cefazoline	-	50 mg/kgBB	PROFILAKSIS	Diulang tiap 3 jam dgn dosis 30 mg/kgBB	1 hari	Dapat dilanjutkan 1x24 jam post operatif dgn dosis 30 mg/kgBB selama 3 x pemberian (dengan acc PIC KPRA)

3. 1.8 Divisi Bedah Onkologi

No	Keadaan klinik/penyakit/tindakan	Rekomendasi antimikroba	Dosis		Empiris/ profilaksis	Interval	Lama pemberian	Keterangan
			Dewasa	Anak				
1.	Operasi Bersih kurang dari 2 jam: - Sentinel node biopsy - Biopsy stereotaktik	-	-	-	-	-	-	-
2.	Operasi bersih lebih dari 2 jam : -Tirodektomi	Cefazoline	IV : 2 gram	-	PROFILAKSIS	8 jam	1 hari	Dosis pertama diberikan 1 jam sebelum operasi dilanjutkan 1 hari paska operasi. Pemberian profilaksis diperpanjang sampai dengan 3-5 hari dengan ACC KPRA
3.	Operasi Terkontaminasi: - Operasi Tumor daerah rongga mulut, saluran nafas - Eksisi tumor mamma (gynecomastia, mamma abberans) - Eksplorasi ductus mamma - Mastektomi - Mastektomi + inflamasi - Rekonstruksi payudara - Operasi lain pada payudara - Eksisi luas lesi kulit - Skin plasty dan repar luka - Flap atau graft pedicle - Tumor otot, tendon, fascia - Amputasi dan disartikulasi ekstremitas - Amputasi dan disartikulasi ektremitas + inflamasi - Ovaryektomi bilateral, salfingo - Ovaryektomi bilateral - Eksisi Soft Tissue Tumor - SkinTumor	Cefazoline	IV : 2 gram		PROFILAKSIS	8 jam	1 hari	Dosis pertama diberikan 1 jam sebelum operasi dilanjutkan 1 hari paska operasi. Pemberian Profilaksis diperpanjang sampai dengan 3-5 hari dengan ACC KPRA
		Gentamycin	IVFD : 5mg/kg	IV : 2,5mg/kg	PROFILAKSIS	24 jam	1 hari	Gentamicin diberikan bila alergi cefazolin

4.	Tumor dengan Ulkus atau terinfeksi	Cloxacillin	IV : 1000 mg	IV : 100-200 mg/kg/hari	EMPIRIS	6 jam	7 hari	

3.2 SMF Mata

No	Keadaan klinik/ penyakit/ tindakan	Rekomendasi antimikroba	Dosis		Empiris/ profilaksis	Interval	Lama pemberian	Keterangan
			Dewasa	Anak				
1.	Bleparitis: Anterior	Topikal : Oxytetracycline 1% salep mata	Salep mata : 4 x sehari	Salep mata : 4 x sehari	EMPIRIS	6 jam	7-14 hari	
		Sistemik : Azithromycin	PO : 250-500mg		EMPIRIS	24 jam	5 hari	
2.	Konjungtivitis : Gonococcal	Sistemik : Ceftriaxone	IM : 1 gram atau IV : 1 gram	IM : max.125 mg atau IV : 25-50 mg/kg	EMPIRIS	IM : Single dose atau IV : 3 hari		IM : bila tidak ada keterlibatan kornea. IV : bila didapatkan keterlibatan kornea
		Topikal : Levofloxacin 0.3%	1 tetes (mata)	1 tetes (mata)	EMPIRIS	5-7 hari		
3.	Konjungtivitis : Klamidial	Sistemik : Erythromycin	PO : 500 mg	PO :12.5 mg/kg	EMPIRIS	6 jam	7 hari	
		Topikal : Oxytetracycline 1% salep mata	Salep mata : 4 x sehari	Salep mata : 4 x sehari	EMPIRIS	6 jam	7 hari	
4.	Konjungtivitis : Purulen Akut	Topikal : Levofloxacin 0,5%	1 tetes (mata)	1 tetes (mata)	EMPIRIS	4-6 jam	5-7 hari	
5.	Keratitis Bakterial	Topikal : Levofloxacin 0,5%	1 tetes (mata)	1 tetes (mata)	EMPIRIS	4-6 jam	7-14 hari	Bila kondisi klinis berat dapat diberikan terapi sesuai ulkus kornea.
		Topikal : Moxifloxacin 0,5%	1 tetes (mata)	1 tetes (mata)	EMPIRIS	4-6 jam	7-14 hari	
6.	Ulkus Kornea Bakterial	Sistemik : Ciprofloxacin	IVFD : 200 mg		EMPIRIS	IVFD : 12 jam	IVFD : 5 hari	Bila didapatkan Hipopion atau ulkus luas disentral
			atau PO : 500 mg			atau	atau	

						PO : 12 jam	PO : 7-14 hari	
		Topikal : Levofloxacin 0,5%	1 tetes (mata)	1 tetes (mata)	EMPIRIS	4-6 jam	7-14 hari	Pada fase akut Antibiotik atopikal dapat diberikan bahkan tiap 5 menit selama beberapa jam pertama Antibiotika <i>fortified</i> dibuat dengan mencampurkan sediaan tetes mata dan injeksi atau mengencerkan sediaan injeksi
		Topikal : Moxifloxacin 0,5%	1 tetes (mata)	1 tetes (mata)	EMPIRIS	4-6 jam	7-14 hari	
		<i>Fortified</i> : Cefazolin F	1 tetes (mata)	1 tetes (mata)	EMPIRIS	Hingga 1 tetes tiap jam	Maksimal 7 hari	
		<i>Fortified</i> : Gentamicin F	1 tetes (mata)	1 tetes (mata)	EMPIRIS	Hingga 1 tetes tiap jam	Maksimal 7 hari	
		<i>Fortified</i> : Tobramycin F	1 tetes (mata)	1 tetes (mata)	EMPIRIS	Hingga 1 tetes tiap jam	Maksimal 7 hari	
		<i>Fortified</i> : Dibekacin F	1 tetes (mata)	1 tetes (mata)	EMPIRIS	Hingga 1 tetes tiap jam	Maksimal 7 hari	
		Intrakameral : Cefuroxime 1mg/0.1ml	Cefuroxime 1 mg/0.1 ml	Cefuroxime 1mg/0.1 ml	EMPIRIS	-		Injeksi intrakameral dilakukan dikamar operasi, biasanya bersamaan dengan aspirasi hipopion
7.	Endophthalmitis	Intravitreal : Vancomycin 1mg/0.1 ml + Ceftazidime 2,25mg/0.1 ml	Vancomycin 0.1 ml + Ceftazidim 0,1 ml	Vancomycin 0.1 ml + Ceftazidim 0,1 ml	EMPIRIS	Dapat diulang setelah 48-72 jam		Injeksi antibiotika intravitreal dilakukan bersamaan dengan tap vitreus dan/ akuos dikamar operasi
		Sistemik : Ciprofloxacin	IVFD : 200 mg atau PO : 750 mg		EMPIRIS	IVFD : 12 jam atau PO : 12 jam	IVFD : 5 hari atau PO : 7-10 hari	
		Topikal : Levofloxacin 0,5%	1 tetes (mata)	1 tetes (mata)	EMPIRIS	4-6 jam	7-14 hari	
		Topikal : Moxifloxacin 0,5%	1 tetes (mata)	1 tetes (mata)	EMPIRIS	4-6 jam	7-14 hari	

8.	Prosedur operasi intraokuli	Sistemik : Ciprofloxacin	500 mg PO		EMPIRIS	12 jam	5 hari	
		Topikal : Levofloxacin 0,5%	1 tetes (mata)	1 tetes (mata)	EMPIRIS	4-6 jam	7-10 hari	
		Intrakameral : Cefuroxime 1mg/0.1ml	Cefuroxime 1 mg/0.1ml	Cefuroxime 1 mg/0.1ml	PROFILAKSIS			Injeksi antibiotika intrakameral dilakukan diakhir operasi intraokuli.

3.3 SMF Obsterti Ginekologi

3.3.1 Profilaksis Bedah Obstetri Ginekologi

No	Keadaan klinik/penyakit/tindakan	Rekomendasi antimikroba	Dosis		Empiris/ profilaksis	Interval	Lama pemberian	Keterangan
			Dewasa	Anak				
1.	Operasi Elektif Bersih Pemasangan implant	Tanpa Antibiotik			PROFILAKSIS			
2.	Operasi Elektif Bersih Terkontaminasi : SC elektif Rekonstruksi tuba Histerektomi supra vaginal Kista ovarium Laparoscopi (diagnostik /terapeutik) Surgical staging Vaginoplasty MOW	Cefazolin	IV : 1 gram		PROFILAKSIS	24 jam	1 hari	
3.	Operasi Emergency Bersih Terkontaminasi : SC CITO KET Kista Ovarium Terpuntir Kuret Abortus (tidak terinfeksi)	Cefazolin	IV : 1 gram		PROFILAKSIS	24 jam	1 hari	
4.	Operasi Elektif Terkontaminasi : Fistel vesico vagina TOA kista terinfeksi	Ceftriaxone	IV : 1 gram		EMPIRIS	12 jam	Sampai ada kultur	
		Gentamicin	IV : 80 mg		EMPIRIS	12 jam	Sampai ada kultur	
5.	Operasi Emergency Terkontaminasi : Kuret abortus septic SC partus kasep Kista/TOA pecah	Ceftriaxone	IV : 1 gram		EMPIRIS	12 jam	Sampai ada kultur	
		Gentamicin	IV : 80 mg		EMPIRIS	12 jam	Sampai ada kultur	

3.3.2 Infeksi Obstetri Ginekologi

No	Keadaan klinik/penyakit/tindakan	Rekomendasi antimikroba	Dosis		Empiris/ profilaksis	Interval	Lama pemberian	Keterangan
			Dewasa	Anak				
1.	Antibiotika terapi Partus kasep dengan infeksi	Ceftriaxone	IV : 1 gram		EMPIRIS	12 jam	Sampai ada kultur	Antibiotika terapi Partus kasep dengan infeksi
		Gentamicin	IV : 80 mg		EMPIRIS	12 jam	Sampai ada kultur	
2.	Hamil dengan UTI	Ceftriaxone	IV : 1 gram		EMPIRIS	12 jam	Sampai ada kultur	Hamil dengan UTI
		Gentamicin	IV : 80 mg		EMPIRIS	12 jam	Sampai ada kultur	
3.	Fluor albus STD	Clindamicin	PO : 300 mg		EMPIRIS	8 jam	7 hari	Fluor albus STD

	Fluor albus Non STD	Doxycyclin	PO : 100 mg		EMPIRIS	12 jam	7 hari	Fluor albus Non STD
4.	Pelvic Inflammation Disease Ringan dan sedang	Clindamicin	PO : 300 mg		EMPIRIS	8 jam	7 hari	Pelvic Inflammation Disease Ringan dan sedang
		Doxycyclin	PO : 100 mg		EMPIRIS	12 jam	7 hari	
	Pelvic Inflammation Disease Berat	Ceftriaxone + Gentamicin + Metronidazole	IV : 1 gram + IV : 500 mg + IV : 500 mg		EMPIRIS	12 jam + 24 jam + 8 jam	7 hari	Pelvic Inflammation Disease Berat
5.	Mastitis	Amoxicillin–Clavulanic Acid	PO : 625 mg		EMPIRIS	8 jam	5 hari	Mastitis
		Eritromycin	PO : 500mg		EMPIRIS	6 jam	5 hari	

3.4. SMF Anak

3.4.1 Divisi Infeksi dan Penyakit Tropik (Parasit)

No	Keadaan klinik/penyakit /tindakan	Kuman penyebab	Rekomendasi antimikroba	Dosis Anak	Empiris/ profilaksis	Interval	Lama pemberian	Keterangan
1.	Ascariasis	Ascarislumbricoides	Pyrantelpamoate	PO : 10 mg/kg/hari	DEFINITIF		1 hari	
			Mebendazole	PO : 100 mg, 2x sehari	DEFINITIF	12 jam	3 hari	
			Albendazole	PO : 400 mg Dosis Tunggal	DEFINITIF		1 hari	
			Ivermectin	PO : 150-200 µg/kg, satu kali	DEFINITIF		1 hari	
2.	Cutaneous Larva Migrans	<i>Ancylostoma caninum</i> <i>Ancylostoma braziliense</i> <i>Uncinaria stenocephala</i>	Albendazole	PO : 15 mg/kg/hari, sekali sehari	EMPIRIS	24 jam	3 hari	
3.	Filariasis	<i>Onchocerca volvulus</i>	Ivermectin	PO : 150 µg/kg once diulang 6-12 bulan	DEFINITIF		1 hari	
		<i>Wuchereria bancrofti</i> , <i>Brugiamalayi</i> , <i>Mansonella streptocerca</i>	Dietil Carbamacin (DEC)	PO : Hari 1 : 1mg/kg Hari 2 : 3 mg/kg/hari terbagi 3 dosis Hari 3 : 3-6 mg/kg/hari terbagi 3 dosis Hari 4–14 : 6 mg/kg/hari terbagi 3 dosis	DEFINITIF	8 jam	4-14 hari	
			Ivermectin	PO : 400 µg/kg Tunggal	DEFINITIF		1 hari	
			Albendazole	400 mg dosis Tunggal	DEFINITIF		1 hari	
		<i>Mansonella ozzardi</i>	Ivermectin	PO : 150 µg/kg Once	DEFINITIF		1 hari	
		<i>Mansonella perstans</i>	Albendazole	PO : 400 mg terbagi 2 dosis	DEFINITIF	12 jam	10 hari	
		<i>Loa loa</i>	Dietil Carbamacin (DEC)	PO : Hari 1 : 1 mg/kg Hari 2 : 3 mg/kg/hari terbagi 3 dosis Hari 3 : 3-6 mg/kg/hari terbagi 3 dosis Hari 4–14 : 6 mg/kg/hari terbagi 3 dosis Hari 15–21 : 9 mg/kg/hari dibagi 3 kali perhari	DEFINITIF		14-21 hari	

3.	Giardiasis	<i>Giardia Lamblia</i>	Metronidazole	PO : 30-40 mg/kg/hari, dibagi 3 kali perhari	DEFINITIF	8 jam	7-10 hari	
			Nitazoxanide	PO : 100 mg/kali, 2 kali perhari	DEFINITIF	12 jam	7 hari	Umur 12-47 bulan
				PO : 200 mg/kali, 2 kali perhari	DEFINITIF	12 jam	7 hari	Umur 4-11 tahun
				PO : 1 tab, 2 kali Perhari	DEFNITIF	12 jam	7 hari	> 12 tahun
			Tinidazole	PO : 50 mg/kg/Hari	DEFINITIF		1 hari	
			Furazolidon	PO : 5-8 mg/kg/hari, dibagi 4 dosis	DEFINITIF	6 jam	10 hari	
4.	Scabies	<i>Sarcoptes scabiei</i>	Inakrin	PO: 6 mg/kg/hari, dibagi 3 dosis	DEFINITIF	8 jam	7-10 hari	
			Permethrin 5% cream	Krim dioleskan keseluruh tubuh, setelah 8 -24 jam dibilas	EMPIRIS		1 kali, dan dapat diulang setelah 1 minggu	
			Lindane lotion		DEFINITIF			
			Ivermectin	PO : 200 µg/kg Sehari Sekali	DEFINITIF		1 hari	Dosis tunggal

3.4.2 Divisi Infeksi dan Penyakit Tropik (Bakteri)

No	Keadaan klinik/penyakit/tindakan	Kuman penyebab	Rekomendasi antimikroba	Dosis anak	Empiris/profilaksis	Interval	Lama pemberian	Keterangan
1.	<i>Bullous impetigo, Cellulitis of unknown Etiology, cellulitis, buccal Pyoderma, Staphylococcal scalded skin syndrome</i>	Staphylococcus aureus	Oxacillin	IV : 15 mg/kg/hari	EMPIRIS	8 jam	10-14 hari	
2.	Diphtheria	<i>Corynebacterium difteria</i>	Erythromycin	40-50 mg/kg/hari dibagi 4 dosis	EMPIRIS	6 jam	10-14 hari	
			Penicillin Procain	IM : 50.000 - 100.000 IU/kg/ hari, dibagi 2 dosis	EMPIRIS	12jam	10-14 hari	Difteri berat
3.	Pharyngitis bakterial		Amoxicillin	50-75 mg/kg/hari dibagi 3 dosis	EMPIRIS	8 jam	10 hari	
			Erythromycin	40 mg/kg/hari dibagi 4 dosis	EMPIRIS	6-12 jam	10 hari	
4.	Demam Typhoid	Demam Typhoid	Chloramphenicol	50-100 mg/kg/hari dibagi 4 dosis secara IV/Po	EMPIRIS	6 jam	7-14 hari	

			Cotrimoxazole	8 mg/kg/hari dari TMP dibagi 2 dosis	DEFINITIF	12 jam	7-14 hari	Bila intoleransi dengan Chloramphenicol
			Ceftriaxone	100 mg/kg/hari IV, IM dibagi 2 dosis	EMPIRIS	12 jam	7-14 hari	Bila tifoid berat
			Ciprofloxacin	15 mg/kg/kali	DEFINITIF	12 jam	10-14 hari	<i>Life threatening</i> , penggunaan tidak melebihi 2 minggu
5.	Tetanus	<i>Clostridium tetani</i>	Metronidazole	30 mg/kg/hari IV	DEFINITIF	8 jam	10-14 hari	
6.	Sepsis		Ampicillin-Sulbactam	200 mg/kgBB/hari iv dalam 4 dosis	EMPIRIS	6 jam	10-14 hari	Pemakaian 3 hari, klinis tidak membaik dan procalcitonin meningkat dapat ditambahkan Gentamicin
			Gentamicin	5-7 mg/kgBB/hari iv dibagi 1-2 dosis	EMPIRIS	12-24 jam	10-14 hari	
			Meropenem	30-120 mg/kgBB/hr	DEFINITIF	8-12 jam + 8 jam	10-14 hari	Berdasar peta kuman atau kultur darah

3.4.3 Divisi Infeksi dan Penyakit Tropik (Jamur)

No	Keadaan klinik/penyakit/tindakan	Rekomendasi antimikroba	Dosis anak	Empiris/profilaksis	Interval	Lama pemberian	Keterangan
1.	Candidosis	Fluconazole	P.O, IV : 6-12 mg/kgBB/hari	EMPIRIS		7-14 hari	
		Micafungin	IV : 4 – 12 mg/kgBB	DEFINITIF		7-14 hari	Curiga strain resisten Candida Albicans atau Non Candida Albicans Candidosis

3.4.4 Divisi Infeksi dan Penyakit Tropik (Virus)

No	Keadaan klinik/penyakit /tindakan	Kuman penyebab	Rekomendasi antimikroba	Dosis anak	Empiris/ profilaksis	Interval	Lama pemberian	Keterangan
1.	Herpes Simplex Virus	<i>Mucocutaneous (normalhost)</i>	Acyclovir	PO : 60-80 mg/kg/hari, dibagi 3-4 dosis	EMPIRIS	6-8 jam	5-7 hari	
			Valacyclovir	PO : 20 mg/kg/dose, 2 kali sehari	DEFINITIF	12 jam	5-7 hari	
		<i>Genital</i>	Acyclovir	PO : 400 mg, 3 kali sehari	EMPIRIS	8 jam	7-10 hari	
			Valacyclovir	PO : 1 gram, 2 kali Per hari	DEFINITIF	12 jam	10 hari	
			Famciclovir	250 mg 3 kali Per hari	DEFINITIF	8 jam	7-10 hari	
		<i>Encephalitis</i>	Acyclovir	IVFD : 60 mg/kg/hari dalam 1-2 jam, dibagi 3 dosis	EMPIRIS	8 jam	21 hari untuk Bayi < 4 bulan	
				4-60 mg/kg/hari	EMPIRIS		Untuk bayi dan anak	
2.	Influenza A dan B		Oseltamivir	Preterm (<38 minggu) = 1 mg/kg/kali 2 kali sehari	DEFINITIF	12 jam	5 hari	
				Preterm (38-40 mgg) = 1.5 mg/kg/kali 2 kali sehari	DEFINITIF	12 jam	5 hari	
				Preterm > 40 mgg = 3 mg/kg/kali 2 kali sehari	DEFINITIF	12 jam	5 hari	
				Term : lahir kurang 8 bulan = 3 mg/kg/kali 2kali sehari	DEFINITIF	12 jam	5 hari	
				Term 9-11 bulan = 3.5 mg/kg/kali 2 kali sehari	DEFINITIF	12 jam	5 hari	
				Term 12-23 bulan = 3,5 mg/kg/kali 2 kali sehari	DEFINITIF	12 jam	5 hari	
				Term 2-12 tahun	DEFINITIF		5 hari	
				BB ≤15 kg = 30 mg	DEFINITIF		5 hari	
				BB 16-23 kg = 45 mg	DEFINITIF		5 hari	
				BB 24-40 kg = 60 mg	DEFINITIF		5 hari	
				BB > 40 kg = 75 mg	DEFINITIF		5 hari	
3.			Acyclovir	80 mg/kg/hari dibagi4 dosis	EMPIRIS	6 jam	7-10 hari	

	Varicella Zostervirus		Acyclovir	IVFD : 30 mg/kg/hari selama 1-2 jam, dibagi dalam 3 dosis	EMPIRIS	8 jam	10 hari	
			Valacyclovir	PO : 20 mg/kg	EMPIRIS		7-10 hari	
4.	Herpes Zoster		Valacyclovir	PO : 1 gram	EMPIRIS	24 jam	7-10 hari	
			Acyclovir	PO : 800 mg	EMPIRIS		7-10 hari	

3.4.5 Divisi Gastrohepatologi

No	Keadaan klinik/penyakit/tindakan	Rekomendasi antimikroba	Dosis		Empiris/ profilaksis	Interval	Lama pemberian	Keterangan
			Dewasa	Anak				
1.	Giardiasis	Metronidazole		P.O : 10 mg/kgBB	EMPIRIS	8 jam	7-10 hari	
2.	Sakit perut berulang	Amoxicillin + Metronidazole		P.O : 25 mg/kgBB + P.O : 20 mg/kgBB	EMPIRIS	12 jam + 12 jam	7-14 hari + 7-14 hari	Dapat tambah <i>Proton Pump Inhibitor</i> (PPI)
3.	Salmonellosis	Choramphenicol		50-100 mg/kg/hari	EMPIRIS	6 jam	10 hari	Bila tidak membaik ganti dengan Cefixime
4.	Acute bacterial gastroenteritis (non thyphoid salmonella)	Cefotaxime		50 mg/kg/dosis	EMPIRIS	6 jam	7-10 hari	
5.	Fever in short bowel syndrome with total parenteral nutriron	Cefotaxime		50 mg/kg/dosis	EMPIRIS	6 jam	7-10 hari	

3.4.6 Divisi Respirologi

No	Keadaan klinik/penyakit/tindakan	Rekomendasi antimikroba	Dosis		Empiris/ profilaksis	Interval	Lama pemberian	Keterangan
			Dewasa	Anak				
1.	Sinusitis Bakterial Akut Ringan	Amoxicillin		P.O : 45-90 mg/kgBB/hari	EMPIRIS	12 jam	7 hari	
	Sinusitis Bakterial Akut sedang disertai muntah	Amoxicillin - Clavulanic Acid		P.O : 80-90 mg/kgBB/hari	EMPIRIS	12 jam	7 hari	
		Ceftriaxone		I.V : 50 mg/kgBB/hr	EMPIRIS	24 jam	7 hari	
	Sinusitis Bakterial Akut Berat	Ceftriaxone		I.V : 100 mg/kgBB/hari	EMPIRIS	12 jam	7 hari	
		Clarithromycin		P.O : 30 mg/kgBB/hari	EMPIRIS	12 jam	10-14 hari	
2.	Pneumonia Anak	Ampicillin		I.V : 50-100 mg/kgBB/hr	EMPIRIS	12 jam	7-14 hari	

	a. Bayi: < 3 bulan:	Gentamicin		I.V : 5-7.5 mg/kgBB/hr	EMPIRIS	12-24 jam	7-14 hari	
		Cefotaxime		I.V : 150-200 mg/kgBB/hr	EMPIRIS	6-8 jam	7-14 hari	Bisa diganti cephalosporin gen 3 yang lain, contoh cefoperazon
		Meropenem		I.V : 30-50 mg/kgBB/hr	DEFINITIF	8 jam	7-14 hari	Diberikan bila sesuai kultur atau acc PIC PPRA
		Amikacin		I.V : 7,5 mg/kgBB	DEFINITIF	12-24 jam	7-14 hari	Diberikan bila sesuai kultur atau acc PIC PPRA
		Amoxicillin		P.O: 80-100 mg/kgBB/hr	EMPIRIS	8 jam	7-14 hari	Kasus ringan rawat jalan
		Cefixime		P.O : 5 mg/kgBB	EMPIRIS	12 jam	7-14 hari	Kasus ringan rawat jalan
3.	Tuberculosis Paru Anak	Rifampicin +		P.O : 10-20 mg/kgBB/hari	EMPIRIS	24 jam		TB paru / kelenjar / efusi pleura : 2HRZ/4HR
		Isoniazid +		P.O : 5-15 mg/kgBB/hari	EMPIRIS			TB milier : 2HRZ(ES)/ 7-10 HR
		Pyrazinamid		P.O : 15-30 mg/kgBB/hari	EMPIRIS			TB ekstra paru : 2HRZ(ES)/10 HR
		Streptomycin		P.O : 15-40 mg/kgBB/hari	EMPIRIS			
		Atau Etambutol		P.O : 20 mg/kgBB/hari	EMPIRIS	24 jam		
	TB MDR	Levofloxacin		7,5-10 mg/kg	EMPIRIS	12-24 jam		Anak < 5th 2 kali sehari, untuk anak > 5th sehari sekali, tidak direkomendasikan untuk anak dengan BB<14kg, Lini kedua: Amikasin (dosis 15-30 mg/kg)
		Moxifloxacin		7.5 -10 mg/kg				
		Kanamisin		15-30 mg/kg				Maksimal 1000 mg
		Ethionamide (Eto)		15-20 mg/kg				
		Protionamid (Pto)		15-20 mg/kg				
		Cycloserin (Cs)		10-20 mg/kg				
		Linezolid		10 mg/kg/dose				
	TB Ekstra Paru: (TB tulang, TB kelenjar, TB sendi)	Rifampicin +		P.O :10-20 mg/kgBB/hari	EMPIRIS	24 jam		Sesuai dengan PPK TB
		Isoniazid +		P.O : 5-15 mg/kgBB/hari	EMPIRIS			

		Pyrazinamid		P.O : 15-30 mg/kgBB/hari	EMPIRIS			
		Streptomycin		P.O : 15-40 mg/kgBB/hari	EMPIRIS			
		Atau Etambutol		P.O : 20 mg/kgBB/hari	EMPIRIS	24 jam		

3.4.7 Divisi Neurologi

No	Keadaan klinik/penyakit/tindakan	Rekomendasi antimikroba	Dosis Anak	Empiris/ profilaksis	Interval	Lama pemberian	Keterangan
1.	Meningitis Bakterialis Usia < 2 bln	Ampicillin-Sulbactam	IV : 200-400 mg/kg/hari	EMPIRIS	8 jam	14-21 hari	
		1.Gentamicin	IV : 6-8 mg/kg/hari	EMPIRIS	12 jam	14-21 hari	
		2.Amikacin	IV : 15mg/kg/hari	EMPIRIS	12 jam	14-21 hari	Diberikan bila sesuai kultur atau acc PIC PPRA
		3.Meropenem	IV : 30-50 mg/kgBB/hr	DEFINITIF	8 jam	14-21 hari	Diberikan bila sesuai kultur atau acc PIC PPRA
	Meningitis Bakterialis Usia 2bln - 5th	Ceftriaxone	IV : 50-100 mg/kg/hari	EMPIRIS	12-24 jam	14-21 hr	
		Meropenem	I.V : 30-50 mg/kgBB/hr	DEFINITIF	8 jam	14-21 hari	Diberikan bila sesuai kultur atau acc PIC PPRA
	Meningitis Bakterialis Usia > 5th	Ceftriaxone	IV : 50-100mg/kg/hari	EMPIRIS	12-24 jam	14-21 hr	
		Meropenem	I.V : 30-50 mg/kgBB/hr	DEFINITIF	8 jam	14-21 hari	Diberikan bila sesuai kultur atau acc PIC PPRA
2.	Encephalitis Anak	1. Asiklovir	10 mg - 15 mg/kgBB I.V	EMPIRIS	6 jam	10-14 hari	Penyebab virus herpes
		2. Gansiklovir	6 - 8 mg/kgBB I.V	EMPIRIS	12 jam	2-6 minggu	Penyebab virus CMV

3.4.8 Divisi Neonatal

3.4.8.1 Perinatologi

No	Keadaan klinik/penyakit /tindakan	Kuman penyebab	Rekomendasi antimikroba	Dosis		Empiris/ profilaksis	Interval	Lama pemberian	Keterangan
				Dewasa	Anak				
1.	Sepsis : Kasus tidak diketahui kuman penyebab		Lini 1 Cefoperazone Sulbactam		50-80 mg/kg/hari	EMPIRIS	12 jam	7-14 hari	Pemakaian antibiotik menyesuaikan dengan klinis dan hasil kultur. Bila sudah didapatkan hasil kultur antibiotic harus disesuaikan dan acc KPRA
			Lini 2 Amikasin		15 mg/kg/hari	EMPIRIS	12-24 jam	7-14 hari	
			Lini 3 Meropenem		40 mg/kg/hari	DEFINITIF	8 jam	7-14 hari	
2.	Infeksi Fungi		Fluconazole		6 mg/kg/hari	EMPIRIS	24 jam	7-14 hari	
			Micafungin		IV : 7-10 mg/kg/hari	DEFINITIF	24 jam	7-14 hari	Sesuai hasil kultur atau persetujuan KPRA
			Nystatin		PO : 0,5 mg/kg/kali	EMPIRIS	8 jam	Selama pemberian tindakan invasive seperti pemasangan infus, long line	Diberikan pada bayi dengan BBL <1500 gram
			Amphotericin B. Liposomal		3 mg/kg/hari	DEFINITIF	12-24 jam	7-14 hari	Sesuai hasil kultur dan persetujuan KPRA
3.	Neonatal Pneumonia		Lini 1 Ampicilin Sulbactam +		100-200 mg/kg/hari	EMPIRIS	12 jam	7-14 hari	
			Gentamicin		5 mg/kg/hari	EMPIRIS	12-24 jam	7-14 hari	
			Lini 2 Amikasin		15 mg/kg/hari	DEFINITIF	12-24 jam	7-14 hari	Diberikan bila sesuai kultur atau acc PIC PPRA
4.	Medical NEC		Ampicilin Sulbactam		100 mg/kgbb/hari	EMPIRIS	8 jam	14 hari	
			IV Gentamicyn		5 mg/kgbb/hari	EMPIRIS	24 jam	14 hari	
			IV Metronidazole		Loading 15 mg/kgbb	EMPIRIS	8 jam	14 hari	

					dilanjutkan maintenance 7,5 mg/kgbb/x				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3.4.8.2 NICU

No	Keadaan klinik/penyakit /tindakan	Kuman penyebab	Rekomendasi antimikroba	Dosis		Empiris/ profilaksis	Interval	Lama pemberian	Keterangan
				Dewasa	Anak				
1.	Sepsis : Kasus tidak diketahui kuman penyebab		Lini 1 Cefoperazone Sulbactam		50-80 mg/kg/hari	EMPIRIS	12 jam	7-14 hari	Pemakaian antibiotik menyesuaikan dengan klinis dan hasil kultur. Bila sudah didapatkan hasil kultur antibiotik harus disesuaikan dan acc KPRA
			Lini 2 Cefepime		25 mg/kg/kali	EMPIRIS	12 jam	7-14 hari	
			Amikasin		15 mg/kg/hari	EMPIRIS	12-24 jam	7-14 hari	
			Lini 3 Meropenem		40 mg/kg/hari	DEFINITIF	8 jam	7-14 hari	
2.	Infeksi Fungi		Fluconazole		6 mg/kg/hari	EMPIRIS	24 jam	7-14 hari	
			Micafungin		IV : 7-10 mg/kg/hari	DEFINITIF	24 jam	7-14 hari	Sesuai hasil kultur atau persetujuan KPRA
			Nystatin		PO : 0,5 mg/kg/kali	EMPIRIS	8 jam	Selama pemberian tindakan invasive seperti pemasangan infus, long line	Diberikan pada bayi dengan BBL < 1500 gram
			Amphotericin B. Liposomal		3 mg/kg/hari	DEFINITIF		7-10 hari	Sesuai hasil kultur atau persetujuan KPRA
3.	Neonatal Pneumonia		Lini 1 Cefoperazone Sulbactam		50-80 mg/kg/hari	EMPIRIS	12 jam	7-14 hari	Pemakaian antibiotic menyesuaikan dengan klinis dan hasil kultur. Bila sudah didapatkan hasil kultur antibiotic harus disesuaikan dan atau acc KPRA
			Lini 2 Cefepime		25 mg/kg/kali	EMPIRIS	12 jam	7-14 hari	
			Amikasin		15 mg/kg/hari	EMPIRIS	12-24 jam	7-14 hari	
			Lini 3 Meropenem		40 mg/kg/hari	DEFINITIF	8 jam	7-14 hari	
4.	Medical NEC		Ampicilin Sulbactam		100 mg/kgbb/hari	EMPIRIS		14 hari	

			Gentamicyn		5 mg/kgbb/hari	EMPIRIS		14 hari	
--	--	--	------------	--	----------------	---------	--	---------	--

3.4.9 Divisi PGD

3.4.9.1 HCU

No.	Keadaan klinik/ penyakit/ tindakan	Rekomendasi antimikroba	Dosis		Empiris/ profilaksis/ definitif	Interval	Lama pemberian	Keterangan
			Dewasa	Anak				
1.	Sepsis	AmpicilinSx		IV : 100-200 mg/kg/hari	EMPIRIS	8 jam	7-14 hari	
		Gentamicin		IV: 5-7 mg/kg/hari	EMPIRIS	12-24 jam	7-14 hari	
		Meropenem		IV : 30 – 50 mg/kgBB/hari	DEFINITIF	8 jam	7-14 hari	Sesuai dengan hasil kultur atau persetujuan KPRA
		Amikasin		IV : 15 mg/kgBB/hari	DEFINITIF	12-24 jam	7-14 hari	Sesuai dengan hasil kultur atau persetujuan KPRA
		Fluconazol		6-12 mg/kg/hari	EMPIRIS	24 jam	7-14 hari	
		Mycafungin		IV : 4-12 mg/kgBB	DEFINITIF		7-14 hari	Sesuai dengan hasil kultur atau persetujuan KPRA
		Amphotericin B. Liposomal		3 mg/kg/hari	DEFINITIF		7-10 hari	Sesuai dengan kultur atau persetujuan KPRA
2.	Pneumonia	Lini 1 : Cefoperazone Sulbactam		25 mg/kg/kali	EMPIRIS	8 jam	7-14 hari	Acc KPRA
		Lini 2 : Amikasin		IV : 15 mg/kgBB/hari	EMPIRIS	12-24 jam	7-14 hari	Sesuai dengan hasil kultur atau persetujuan KPRA

		Lini 3 : Meropenem		IV : 30-50 mg/kgBB/hari	DEFINITIF	8 jam	7-14 hari	Sesuai dengan hasil kultur atau persetujuan KPRA
--	--	--------------------	--	-------------------------	-----------	-------	-----------	--

3.4.9.2 PICU

No.	Keadaan klinik/ penyakit/tindakan	Rekomendasi antimikroba	Dosis		Empiris/ profilaksis/ definitif	Interval	Lama pemberian	Keterangan
			Dewasa	Anak				
1.	Sepsis	Ampicilin Sx		IV : 100-200 mg/kg/hari	EMPIRIS	8 jam	7-14 hari	
		Gentamicin		IV : 5-7 mg/kg/hari	EMPIRIS	12-24 jam	7-14 hari	
		Meropenem		IV : 30-50 mg/kgBB/hari	DEFINITIF	8 jam	7-14hari	Sesuai dengan hasil kultur atau persetujuan KPRA
		Amikasin		IV : 15 mg/kgBB/hari	DEFINITIF	12-24 jam	7-14hari	Sesuai dengan hasil kultur atau persetujuan KPRA
		Fluconazol		6-12 mg/kg/hari	EMPIRIS	24 jam	7-14 hari	
		Mycafungin		IV : 4-12 mg/kgBB	DEFINITIF		7-14hari	Sesuai dengan hasil kultur atau persetujuan KPRA
		Amphotericin B Liposomal		3 mg/kg/hari	DEFINITIF		7-10 hari	Sesuai dengan hasil kultur atau persetujuan KPRA
2.	Pneumonia	Lini 1 Cefoperazone Sulbactam		25 mg/kg/kali	EMPIRIS	8 jam	7-14 hari	Acc dari KPRA

		Lini 2 Amikasin		IV : 15 mg/kgBB/hari	EMPIRIS	12-24 jam	7- 14hari	Sesuai dengan hasil kultur atau persetujuan KPRA
		Lini 3 Meropenem		IV : 30-50 mg/kgBB/hari	DEFINITIF	8 jam	7-14 hari	Sesuai dengan hasil kultur atau persetujuan KPRA

3.4.10 Divisi Kardiologi

No.	Keadaan klinik/ penyakit/tindakan	Rekomendasi antimikroba	Dosis		Empiris/ profilaksis	Interval	Lama pemberian	Keterangan
			Dewasa	Anak				
1.	Demam Rematik 1.1 Primer	Benzatin Penicillin (BPG)		I.M : 600.000-900.000 iu (BB<30kg)	EMPIRIS	24 jam	1 kali atau 4 minggu	
				I.M : 1,2 juta iu (BB>30kg)	EMPIRIS	24 jam	4 minggu	
		Erithromycin		P.O : 50 mg/kgBB	EMPIRIS	6 jam	10 hari	Bila alergi terhadap BPG
	1.2 Pencegahan sekunder	Benzatin Penicillin (BPG)		I.M : 600.000-900.000 IU (BB< 30 kg)	PROFILAKSIS	24 jam	1 kali atau 4 minggu	Tanpa karditis selama 5 tahun atau sampai usia 21 tahun Dengan karditis tanpa struktur katup selama 10 tahun atau sampai usia 21 tahun
				I.M : 1,2 juta IU (BB>30kg)	PROFILAKSIS	24 jam	1 kali atau 4 minggu	Dengan karditis dan kelainan struktur katup selama 10 tahun atau sampai usia 40 tahun
		Erithromycin		P.O : 250 mg	PROFILAKSIS	12 jam	10 hari	

3.4.11 Divisi Nefrologi

No.	Keadaan klinik/ penyakit/tindakan	Rekomendasi antimikroba	Dosis		Empiris/ profilaksis	Interval	Lama pemberian	Keterangan
			Dewasa	Anak				
1.	Infeksi Saluran Kemih (ISK)	Amoxicillin Clavulanic Acid		10-25 mg/kg/x (maks 1gram)	EMPIRIS	3x/hari	7 hari – 10 hari	Intra vena atau per oral
		Cotrimoxazole (Trimethoprim 1 mg, Sulfametoksazole 5mg		3-4 mg/kg/x TMP	EMPIRIS	2x/hari	7-10 hari	Intra vena atau per oral
		Nitrofurantoin oral		5-7 mg/kg BB/hari	Definitif	4x/hari	7-10 hari	Oral
		Ceftriaxone		25 mg/kg/x (maks 1 gr), severe : 50 mg/kg/x (maks 2 gr)	EMPIRIS	2x/hari	7-14 hari	Renal adjustment
		Gentamicin		IV: 5-7 mg/kg/hari	EMPIRIS	12-24 jam	7-10 hari	Renal adjustment
		Amikacin		15 mg/kg/hari	DEFINITIF	8 jam	7-14 hari	Renal adjustment (Sesuai dengan hasil kultur dan persetujuan KPRA)
		Cefepime		25 mg/kg/kali	DEFINITIF	12 jam	7-14 hari	Sesuai hasil kultur dan persetujuan KPRA

3.4.12 Divisi Nutrisi

No.	Keadaan klinik/ penyakit/tindakan	Rekomendasi antimikroba	Dosis		Empiris/ profilaksis	Interval	Lama pemberian	Keterangan
			Dewasa	Anak				
1.	Gizi Buruk	Ampicillin – Sulbactam		100 mg/kgBB/hari	EMPIRIS	8 jam	7-10 hari	

3.5 INTENSIVE CARE UNIT (ICU)

No.	Keadaan klinik	Sumber infeksi	Rekomendasi antimikroba	Dosis dewasa	Interval	Jenis antibiotik	Lama pemberian	Keterangan
1.	INFEKSI BAKTERI/ SEPSIS	A. SALURAN PERNAPASAN	Lini pertama Ceftazidim + Amikasin Lini kedua Meropenem + Tigesiklin	IV : 2 g IV : 15 – 30 mg/kgbb/hari IV : 20 – 40 mg/kg IV : 100 mg	8 jam 24 jam 8 jam 12 jam	EMPIRIS	10-14 hari atau sampai ada hasil kultur definitif	Dapat dipertimbangkan penggunaan moksifloksasin jika terdapat kontra indikasi Amikasin
		B. SALURAN KENCING	Lini pertama Ceftazidim + Amikasin Lini kedua Meropenem + Tigesiklin	IV : 2 g IV : 15 – 30mg/kgbb/hari IV : 20 – 40mg/kg IV : 100mg	8 jam 24 jam		10-14 hari atau sampai ada hasil kultur definitif	Dapat dipertimbangkan penggunaan kombinasi antibiotik yang lain seperti fosfomisin dan gentamisin.
		C. SALURAN PENCERNAAN dan lain - lain	Meropenem Lini kedua Amikasin + Metronidazole	IV : 20 – 40 mg/kg IV : 15 – 30mg/kgbb/hari IV : 500 mg	8 jam 24 jam 8 jam		10-14 hari atau sampai ada hasil kultur definitif	Antibiotik ini dapat dikombinasikan dengan Jenis Antibiotik lain sesuai dengan tingkat keparahan penyakit (Riwayat pengobatan sebelumnya, keadaan klinis dan hasil pemeriksaan penunjang) dan sumber infeksi
2.	INFEKSI JAMUR		1. Fluconazole	IV : Loading 6 mg/kgbb pada hari pertama dilanjutkan 3 – 4 mg/kgbb	12 jam	EMPIRIS	14 hari atau sampai ada hasil kultur definitif	

			2. Mikafungin	IV : 100 mg	24 jam	EMPIRIS	14 hari atau sampai ada hasil kultur definitif	
--	--	--	---------------	-------------	--------	---------	--	--

3.6 INTENSIVE CARE UNIT (ICU) COVID-19 / IPIT

No.	Keadaan Klinik	Sumber infeksi	Rekomendasi antimikroba	Dosis dewasa	Interval	Jenis antibiotik	Lama pemberian	Keterangan
1.	INFEKSI BAKTERI/ SEPSIS	A. SALURAN PERNAPASAN	Lini pertama Ceftazidim + Amikasin Lini kedua Meropenem + Tigesiklin	IV : 2 g IV : 15 – 30 mg/kgbb/hari IV : 20 – 40 mg/kg IV : 100 mg	8 jam 24 jam 8 jam 12 jam	EMPIRIS	10-14 hari atau sampai ada hasil kultur definitif	Dapat dipertimbangkan penggunaan moksifloksasin jika terdapat kontra indikasi Amikasin
		B. SALURAN KENCING	Lini pertama Ceftazidim + Amikasin Lini kedua Meropenem + Tigesiklin	IV : 2 g IV : 15 – 30mg/kgbb/hari IV : 20 – 40mg/kg IV : 100mg	8 jam 24 jam		10-14 hari atau sampai ada hasil kultur definitif	Dapat dipertimbangkan kombinasi antibiotik yang lain seperti fosfomisin dan gentamisin.
		C. SALURAN PENCERNAAN dan lain – lain	Meropenem Lini kedua Amikasin + Metronidazole	IV : 20 – 40 mg/kg IV : 15 – 30mg/kgbb/hari IV : 500 mg	8 jam 24 jam 8 jam		10-14 hari atau sampai ada hasil kultur definitif	Antibiotik ini dapat dikombinasikan dengan Jenis Antibiotik lain sesuai dengan tingkat keparahan penyakit (Riwayat pengobatan sebelumnya, keadaan klinis dan hasil pemeriksaan penunjang) dan sumber infeksi
2.	INFEKSI JAMUR		1. Fluconazole	IV : Loading 6 mg/kgbb pada hari pertama dilanjutkan 3 – 4 mg/kgbb	12 jam	EMPIRIS	14 hari atau sampai ada hasil kultur definitif	

			2. Mikafungin	IV : 100 mg	24 jam	EMPIRIS	14 hari atau sampai ada hasil kultur definitif	
--	--	--	---------------	-------------	--------	---------	--	--

3.7 SMF ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF

No.	Keadaan klinik	Rekomendasi	Dosis dewasa	Dosis anak	Jenis	Interval	Lama pemberian	Keterangan
1.	Tindakan intervensi nyeri seperti neurolitik simpatetik block untuk manajemen nyeri akut, kronik dan kanker	Cefazolin	IV : 2 g	IV : 15-20 mg/kg	PROFILKASIS	24 jam	1 hari	
2.	<i>Superficial soft tissue infection</i> pasca tindakan regional anestesia	Lini 1 Cloxacillin + Clindamisin Lini 2 Ceftriaxone + Metronidazole	IV : 500 mg PO : 300 – 600 mg IV : 1 g IV : 500 mg	100-200 mg/kg/hari PO 20-30 mg/kg/hari	EMPIRIS	6 jam 6 jam 12 jam 6 jam	4-6 minggu (Sampai didapatkan hasil kultur) 4-6 minggu (Sampai didapatkan hasil kultur)	

3.8 SMF PARU

No.	Keadaan klinik/ Penyakit/tindakan	Rekomendasi antimikroba	Dosis		Empiris/ profilaksis	Interval	Lama pemberian	Keterangan
			Dewasa	Anak				
1.	Pneumonia komuniti (CAP / Community Acquired Pneumonia) Rawat Jalan Pasien tanpa komorbid atau tidak mempunyai riwayat pemakaian antibiotik 3 bulan sebelumnya	Cefixime	PO : 100; 200 mg		EMPIRIS	12 jam	7 hari	Dengan mempertimbangkan pemilihan antibiotik berdasarkan keadaan klinis, riwayat penggunaan antibiotik sebelumnya atau riwayat alergi; Bila pasien sebelumnya sudah mendapatkan Cefadroxil dari faskes sebelumnya, maka bisa diberikan Cefixime atau pada pasien yang alergi obat amoxicillin clavulanic acid maka bisa diganti dengan obat yang lain yang tidak alergi
2.	Pneumonia komuniti (CAP / Community Acquired Pneumonia) Rawat Jalan Pasien dengan kecurigaan pneumonia atipikal	Azithromycin	PO : 250; 500 mg		EMPIRIS	24 jam	3-5hari	Pemilihan antibiotika berdasarkan keadaan klinis, riwayat pengobatan sebelumnya, riwayat alergi dan biaya.
		Clarithromycin	PO : 250; 500 mg		EMPIRIS	12 jam	7 hari	
		Levofloxacin	PO : 750 mg		EMPIRIS	24 jam	7 hari	
3.	Pneumonia komuniti (CAP/ Community Acquired Pneumonia) Rawat Jalan dengan Komorbid	Levofloxacin	PO : 750 mg		EMPIRIS	24 jam	7 hari	Pasien dengan komorbid atau mempunyai riwayat pemakaian antibiotik 3 bulan sebelumnya
		Amoxicillin Clavulanic Acid (harus berdasarkan hasil kultur)	PO : 625 mg		EMPIRIS	8 jam	7 hari	Dengan mempertimbangkan pemilihan antibiotik berdasarkan keadaan klinis, riwayat penggunaan antibiotik sebelumnya atau riwayat alergi, serta biaya;
		Moxifloxacin (harus berdasarkan hasil kultur)	PO : 400 mg		EMPIRIS	24 jam	7 hari	Moxifloxacin diberikan pada pasien yang mengalami gangguan ginjal, atau pasien sudah mendapatkan levofloxacin sebelumnya yang tidak ada

								perbaikan (harus mendapat persetujuan PGA SMF)
4.	Pneumonia komuniti (CAP / Community Acquired Pneumonia) Rawat Inap Biasa	Ampicillin Sulbactam	IV : 1 gram + 500 mg		EMPIRIS	6-8 jam	7 hari	Dengan mempertimbangkan pemilihan antibiotik berdasarkan keadaan klinis, riwayat penggunaan antibiotik sebelumnya atau riwayat alergi, serta biaya;
		Ceftriaxone	IV : 1 gram		EMPIRIS	12 jam	7 hari	
		Ceftriaxone + Azithromycin	IV : 1 gram + PO : 500 mg IVFD : 500 mg		EMPIRIS	12 jam 24 jam	7 hari	
		Levofloxacin	PO : 750 mg IVFD : 750 mg		EMPIRIS	24 jam	7 hari	
		Cefoperazone + Azithromycin	IV : 1 gram + PO : 500 mg IVFD : 500 mg		EMPIRIS	12 jam 24 jam	7 hari	
		Moxifloxacin	PO : 400 mg IVFD : 400 mg		EMPIRIS	24 jam	7 hari	Bila ada bukti penurunan fungsi ginjal
		Amikacin	IV : 1000 mg		EMPIRIS	24 jam	7 hari	Dapat diberikan, bila tidak terjadi perbaikan klinis selama 3 hari dirawat atau terjadi perburukan kondisi dengan pemberian antibiotika sebelumnya (dibuktikan dengan peningkatan marker infeksi (Procalcitonin / CRP). Dimana hasil uji sensitivitas antibiotika belum keluar.
5.	Pneumonia komuniti (CAP / Community Acquired Pneumonia) Rawat Inap Biasa Kuman atipikal	Azithromycin	PO : 500 mg IV : 250 mg ; 500 mg		EMPIRIS	24 jam	3-5 hari	Pemilihan antibiotika berdasarkan keadaan klinis, riwayat pengobatan sebelumnya, riwayat alergi dan biaya

		Clarithromycin	PO : 250 mg		EMPIRIS	12 jam	7 hari	
		Levofloxacin	PO : 750 mg IVFD : 750 mg		EMPIRIS	24 jam	7 hari	
		Doxycycline	PO : 200 mg dilanjutkan 100 mg		EMPIRIS	12 jam	7 hari	
6.	Pneumonia komuniti (CAP/ Community Acquired Pneumonia) Rawat Inap Intensif tanpa faktor resiko infeksi Pseudomonas	Ceftriaxone + Levofloxacin	IV : 1 gram + PO : 500 mg IV : 750 mg		EMPIRIS	12 jam + 24 jam	7 hari	
		Ampicillin- Sulbactam + Levofloxacin	IV : 1,5 gram + PO : 750 mg IV : 750 mg		EMPIRIS	6 jam + 24 jam	7 hari	
		Ceftriaxone + Azithromycin	IV : 1 gram + PO : 500 mg IV : 250 mg; 500 mg		EMPIRIS	12 jam + 24 jam	7 hari	Pemilihan antibiotika berdasarkan keadaan klinis, riwayat pengobatan sebelumnya, riwayat alergi dan biaya
		Ampicillin- Sulbactam + Azithromycin	IV : 1,5 gram + PO : 750 mg IV : 500 mg		EMPIRIS	6 jam + 24 jam	7 hari	(terutama pneumonia atipikal)
		Amikacin	IV : 1000 mg		EMPIRIS	24 jam	7 hari	Dapat diberikan, bila tidak terjadi perbaikan klinis selama 3 hari dirawat di ruang intensif, dengan pemberian antibiotika sebelumnya serta hasil uji sensitivitas antibiotika belum keluar.

		Ampicillin-Sulbactam + Azithromycin	IV : 1,5 gram + PO : 750 mg IV : 500 mg		EMPIRIS	6 jam + 24 jam	7 hari	Pemilihan antibiotika berdasarkan keadaan klinis, riwayat pengobatan sebelumnya, riwayat alergi dan biaya; Pada pasien yang tidak bias dirawat diruang intensive atau pasien TB MDR karena keterbatasan ruangan, maka terapi bisa dioptimalkan sesuai dengan klinis pasien dan konfirmasi PGA KPRA.
7.	Pneumonia komuniti (CAP/ Community Acquired Pneumonia) Rawat Inap Intensif Risiko Pseudomonas Penghasil kuman ESBL di ruang ICU	Meropenem + Levofloxacin	IV : 1 g + IV : 5-7 mg/kg + PO : 500 mg IV : 500 mg		EMPIRIS	8 jam + 24 jam	7 hari	Risiko Psudomonas Penghasil kuman ESBL Sesuai klinis bisa diberikan kombinasi dengan Fluoroquinolon respirasi atau amikacin; bila memberat dilakukan ekskalasi konfirmasi PGA KPRA. Pemilihan antibiotika berdasarkan keadaan klinis, riwayat pengobatan sebelumnya, riwayat alergi dan biaya; Pada pasien yang tidak bisa dirawat diruang intensive / HCU atau pasien TB MDR karena keterbatasan ruangan, maka terapi bisa dioptimalkan sesuai dengan klinis pasien dan konfirmasi KPRA
		Ceftazidime + Levofloxacin	IV : 1 g + IV : 750 mg		EMPIRIS	12 jam + 24 jam	7 hari	
		Piperacilin Tazobactam + Levofloxacin	IV : 4,5 g + IV : 750 mg		EMPIRIS	6 jam + 24 jam	7 hari	
		Amikacin	IV : 1000 mg		EMPIRIS	24 jam	7 hari	
8.	Bronkitis	Azithromycin	PO : 500 mg		EMPIRIS	24 jam	3-5 hari	Kuman atipikal ; Chlamidiasp Mycoplasma Legionella
		Levofloxacin	PO : 500–750 mg		EMPIRIS	12 jam	7 hari	
		Cefixime	PO : 100 mg		EMPIRIS	12 jam	7 hari	Dengan mempertimbangkan pemilihan antibiotik berdasarkan keadaan klinis, riwayat penggunaan antibiotik sebelumnya atau riwayat alergi; Bila pasien sebelumnya sudah mendapatkan Cefadroxil dari PKM,

								maka bisa diberikan Cefixime
9.	Pneumonia Aspirasi	Ampicillin Sulbactam	IV : 1,5 gram		EMPIRIS	6 jam	1-2 minggu	Pada pasien-pasien risiko tinggi terjadi pneumonia aspirasi (penurunan kesadaran, tirah baring lama, gangguan koordinasi dll)
		Levofloxacin	IVFD : 750 mg		EMPIRIS	24 jam	7 hari	Pilihan kedua, bila alergi atau kontra indikasi pemberian Ampicillin sulbactam
10.	Abses Paru / Empiema	Ceftriaxone + Levofloxacin + Metronidazole	IV : 1 gram IVFD : 750 mg IVFD : 500 mg		EMPIRIS	12 jam 24 jam 8 jam	1-2 minggu	
		Ceftriaxone + Gentamycin + Metronidazole	IV : 1 gr IV : 800 mg IVFD : 500 mg		EMPIRIS	12 jam 24 jam 8 jam	1-2 minggu	
		Ampicillin Sulbactam	IV : 1,5 gram		EMPIRIS	6 jam	1-2 minggu	
		Clindamycin	PO : 150–300 mg		EMPIRIS	6 jam	4-6 minggu	
11.	COVID-19 ringan (rawat jalan)	Favipiravir (oral)	600 mg (sampai 7 hari maksimal)	Tidak ada data	EMPIRIS	12 jam	Tidak lebih dari 7 hari	Digunakan pada mereka yang terduga dan atau terkonfirmasi COVID-19, sampai ada antiviral oral lain yang lebih superior
		Oseltamivir (oral)	75 mg	Usia 1 – 12 tahun : 2 mg/kg BB (max 75 kg)	EMPIRIS	12 jam	5-10 hari	Digunakan pada mereka yang terduga dan atau terkonfirmasi COVID-19 bila Favipiravir tidak ada atau menjadi kontra indikasi
12.	COVID-19 sedang	Remdesivir	200 mg (hari 1) selanjutnya 100 mg per 24 jam		EMPIRIS	24 jam	7-10 hari	Merupakan antiviral pilihan utama pada COVID-19 derajat berat sampai kritis

13.	COVID-19 berat / kritis / sepsis	Favipiravir (oral)	1600 mg (hari 1) selanjutnya 600 mg (sampai 7 hari maksimal)	Tidak ada data	EMPIRIS	12 jam	Tidak lebih dari 7 hari	Digunakan pada mereka yang terduga dan atau terkonfirmasi COVID-19, sampai ada antiviral lain yang lebih superior
		Oseltamivir (oral)	75 mg	Usia 1 – 12 tahun : 2 mg/kg BB (max 75 kg)	EMPIRIS	12 jam	5-10 hari	Digunakan pada mereka yang terduga dan atau terkonfirmasi COVID-19 bila Favipiravir tidak ada atau menjadi kontra indikasi
		Remdesivir	200 mg (hari 1) selanjutnya 100 mg per 24 jam		EMPIRIS	24 jam	7-10 hari	Merupakan antiviral pilihan utama pada COVID-19 derajat sedang sampai kritis
		Favipiravir (oral)	1600 mg (hari 1) selanjutnya 600 mg (sampai 7hari maksimal)	Tidak ada data	EMPIRIS	12 jam	Tidak lebih dari 7 hari	Digunakan pada mereka yang terduga dan atau terkonfirmasi COVID-19, bila Remdesivir tidak tersedia, atau terjadi gangguan hepar berat pada pasien
		Oseltamivir (oral)	75 mg	Usia 1 – 12 tahun : 2 mg/kg BB (max 75 kg)	EMPIRIS	12 jam	5-10 hari	Digunakan pada mereka yang terduga dan atau terkonfirmasi COVID-19 bila Remdesivir / Favipiravir tidak ada atau menjadi kontra indikasi

3.9 SMF Neurologi

No.	Keadaan klinik/ Penyakit/tindakan	Rekomendasi antimikroba	Dosis		Empiris/ profilaksis	Interval	Lama pemberian	Keterangan
			Dewasa	Anak				
1.	Meningitis	Ceftriaxone	IV : 2–3 gram		EMPIRIS	12 jam	1-2 minggu	Lini 1 dengan persetujuan KPRA
		Ceftazidime	IV : 6 gram		EMPIRIS	8 jam	1-2 minggu	Lini 2 dengan persetujuan KPRA
2.	Meningitis Tuberkulosis	Isoniazid + Rifampin + Pyrazinamide + Streptomycin	PO : 300 mg + PO : 600 mg + PO :15-30 mg/kg + IM : 1 gram		EMPIRIS	24 jam	7 bulan + 7 bulan + 2 bulan + 2 bulan	
3.	Ensefalitis	Acyclovir	IV : 10 mg/kg		EMPIRIS	8 jam	3 minggu	
		Foscarnet	IV : 60 mg/kg		EMPIRIS	8 jam	3 minggu	Jika resisten Acyclovir
		Acyclovir	PO : 10 mg/kg		EMPIRIS	8 jam	2 minggu	
		Ganciclovir	Induksi : IV : 5 mg/kgbb Pemeliharaan : IV : 5 mg/kgbb		EMPIRIS	Induksi : 12 jam Pemeliharaan : 24 jam	Induksi : 2-3 minggu	
		Foscarnet	Induksi : IV : 60 mg/kgbb Pemeliharaan : IV : 60-120 mg/kgbb		EMPIRIS	Induksi : 8 jam Pemeliharaan : 24 jam	Induksi : 2-3 minggu	
		Acyclovir	IV : 10 mg/kgbb		EMPIRIS	8 jam		

		Foscarnet	IV : 60 mg/kgbb		EMPIRIS	8 jam	2-3 minggu	
		Foscarnet	IV : 5 mg/kgbb		EMPIRIS	12 jam		
		Doxycycline	PO : 100 mg		EMPIRIS	12 jam		
4.	Tetanus	Metronidazole	IVFD : 500 mg		EMPIRIS	8 jam	10 hari	

3.10 SMF Gigi dan Mulut

No	Keadaan klinik/penyakit/tindakan	Kuman penyebab	Rekomendasi antimikroba	Dosis		Empiris/ profilaksis	Interval	Lama pemberian	Keterangan
				Dewasa	Anak				
1.	Infeksi gusi dan jaringan pendukung : Gingivitis, Periodontitis, Perikoronitis	Campuran bakteri anaerob & aerob oral floral	Amoxicillin	PO : 500 mg		EMPIRIS	8 jam	5 hari	
			Amoxicillin – Clavulanic Acid	PO : 625 mg		EMPIRIS	8 jam	5 hari	
2.	Infeksi Jaringan Keras : Alveolitis, Subperiostitis, Periotitis, Osteomyelitis	Campuran bakteri anaerob & aerob oral floral	Amoxicillin	PO : 500 mg		EMPIRIS	8 jam	5 hari	
			Amoxicillin – Clavulanic Acid	PO : 625 mg		EMPIRIS	8 jam	5 hari	
3.	Infeksi Gigi : Pulpitis	Campuran bakteri anaerob & aerob oral floral	Amoxicillin	PO : 500 mg		EMPIRIS	8 jam	5 hari	
			Amoxicillin – Clavulanic Acid	PO : 625 mg		EMPIRIS	8 jam	5 hari	
			Lincomycin	PO : 500 mg		EMPIRIS	8 jam	5 hari	
4.	Infeksi Kelenjar Air Liur : Parotitis, Sialadenitis, Sialodochitis, Periadentitis	Campuran bakteri anaerob & aerob oral floral	Amoxicillin – Clavulanic Acid	PO : 625 mg		EMPIRIS	8 jam	5 hari	
			Ciprofloxacin	PO : 500 mg		EMPIRIS	8 jam	5 hari	
			Clindamycin	PO : 300 mg		EMPIRIS	8 jam	5 hari	
5.	Abses : Spasium dan Dentoalveolar Abses, Periodontal Abses, Pulpitis Purulenta, Osteomyelitis Purulenta	Campuran bakteri anaerob dan aerob oral floral	Amoxicillin – Clavulanic Acid	PO : 625 mg		EMPIRIS	8 jam	5 hari	
			Metronidazole	PO : 500 mg		EMPIRIS	8 jam	5 hari	
			Ciprofloxacin	PO : 500 mg		EMPIRIS	12 jam	5 hari	Pada infeksi berat dapat diberikan setiap 8 jam
			Clindamycin	PO : 300 mg		EMPIRIS	8 jam	5 hari	
6.	Gangren Radik & Gangren Pulpa Proekstraksi Gigi dengan GA sebagai persiapan operasi jantung	Campuran bakteri anaerob dan aerob oral floral	Amoxicillin	PO : 2 g		PROFILAKSIS	30 menit Pre Operasi		

3.11 SMFJANTUNG

No.	Keadaan klinik/ penyakit/tindakan	Rekomendasi antimikroba	Dosis		Empiris/ profilaksis	Interval	Lama pemberian	Keterangan
			Dewasa	Anak				
1.	Pemberian antibiotik profilaksis untuk prosedur dental pada populasi risiko tinggi. No allergy to penicillin or ampicillin	Amoxicillin	PO : 2 g	IV/PO : 50 mg/kg	PROFILAKSIS	Single dose	30-60 menit sebelum tindakan	• Pasien dengan katup prostetik termasuk katup transkateter atau semua yang menggunakan material prostetik untuk perbaikan katup jantung; • Pasien dengan riwayat IE
		Ampicillin	IV : 2 g	IV/PO : 50 mg/kg	PROFILAKSIS	Single dose	30-60 menit sebelum tindakan	

3.12 SMF KULIT dan KELAMIN

No.	Keadaan klinik/ penyakit/tindakan	Kuman Penyebab	Rekomendasi antimikroba	Dosis		Empiris/ profilaksis	Interval	Lama pemberian	Keterangan
				Dewasa	Anak				
1.	Dermatomikosis Tinea korporis Tinea kruris	<i>Microsporum</i> <i>Trichophyton</i> <i>Epidermophyton</i>	Topikal : Ketoconazole	Krim 2%		EMPIRIS	12 jam	2-6 minggu	
			Topikal : Terbinafine	Krim 1%		EMPIRIS	12 jam	1-2 minggu	
			Sistemik : Terbinafine	PO : 250 mg/hari	PO : 3-6 mg/kg/hari	EMPIRIS	24 jam	2-4 minggu 2 minggu (anak)	
			Sistemik : Itraconazole	PO : 100 mg/hari	PO : 5 mg/kg/hari	EMPIRIS	24 jam	1 minggu	
			Sistemik : Fluconazole	PO : 150-300 mg/hari		EMPIRIS	24 jam	4-6minggu	
2.	Dermatomikosis Tinea manus Tinea pedis	<i>Trichophyton</i> <i>Epidermophyton</i>	Topikal : Ketoconazole	Krim 2 %		EMPIRIS	12 jam	2-6 minggu	
			Topikal : Terbinafine	Krim 1 %		EMPIRIS	12 jam	1-2 minggu	
			Sistemik : Terbinafine	PO : 250 mg/hari	PO : 3-6 mg/kg/hari	EMPIRIS	24 jam	2 minggu (anak)	
			Sistemik : Itraconazole	PO : 200 mg	PO : 5 mg/kg/hari	EMPIRIS	12 jam	1 minggu 2 minggu (anak)	
			Sistemik : Fluconazole	PO : 150 mg/minggu		EMPIRIS	24 jam	3-4 minggu	
3.	Dermatomikosis Onikomikosis	Dermatofit : <i>Trichophyton</i> Nondermatofit : <i>Candidaspp</i>	Sistemik : Itraconazole	PO : 200 mg/hari atau PO : pulse 400 mg/hari	BB < 20 kg : 5 mg/kg/hari BB 20-40 kg : 100 mg/hari BB 40-50 kg : 200 mg/hari BB > 50 kg : 200 mg, 2x /hari	EMPIRIS		200 mg/hari untuk 2- 3 bulan 400 mg/hari selama 1 minggu/bulan untuk 2-3 bulan	

			Sistemik : Fluconazole	PO : 150-300 mg/mgg	PO : 3-6 mg/kg/minggu	EMPIRIS	1 minggu	3-6 bulan(anak) 3-12 bulan(dewasa)	
			Sistemik : Terbinafine	PO : 250 mg/hari	BB 10-20 kg : 62.5 mg/hari BB 20-40 kg : 125 mg/hari BB > 40 kg : 250 mg/hari	EMPIRIS	24 jam	6-12 minggu	
4.	Dermatomikosis Tinea kapitis	<i>Microsporum Trichophyton</i>	Sistemik : Griseofulvin	PO : 20-25 mg/kg/hari	Usia 1 bulan - 2 thn: 10 mg/kg/hari Usia ≥ 2 tahun : 20-25 mg/kg/hari (mikro) Usia ≥ 2 tahun : 10-15 mg/kg/hari (ultramikro)	EMPIRIS	24 jam	6-8 minggu	
			Sistemik : Terbinafin	PO : 250 mg/hari	BB <20 kg : 62,5 mg/hari BB 20-40 kg : 125 mg/hari BB > 40 kg : 250 mg/hari	EMPIRIS	24 jam	2-8 minggu(dewasa) 2-4 minggu(anak)	Efektif untuk <i>Trichophyton</i>
			Sistemik : Itraconazole	PO : 5 mg/kgbb/hari	PO : 3-5 mg/kg/hari atau PO : 5 mg/kg/hari	EMPIRIS	24 jam	2-4 minggu (Dewasa & Anak) / 1 minggu / bulan dalam 2-3 bulan	Efektif untuk <i>Trichophyton</i>
			Sistemik: Fluconazole	PO : 6 mg/kg/hari	PO : 6 mg/kg/hr atau PO : 6 mg/kg/mg		1 minggu	3-6 minggu (Dewasa & Anak) / 8-12 minggu (Anak)	
5.	Dermatomikosis Pitiriasis versikolor	<i>Malassezia furfur</i>	Topikal : Ketoconazole	Sampo 2%		EMPIRIS	24 jam	Selama 3 hari berturut-turut	5 menit sebelum mandi lalu dibilas air
			Topikal : Seleniumsulfide	Sampo 1,8%		EMPIRIS	24 jam atau 48 jam	Selama 3 hari berturut-turut, diulang 1 mgg kemudian, terapi rumatan : 1x tiap 3 bulan	10 menit sebelum mandi lalu dibilas air atau malam sebelum tidur

			Topikal : Zinc pyrithione	Sampo		EMPIRIS	24 jam	2 minggu	5 menit sebelum mandi lalu dibilas air
			Sistemik : Ketoconazole	PO : 200 mg/hari atau PO : 400 mg		EMPIRIS	24 jam	7-10 hari atau Dosis tunggal	Lini pertama
			Sistemik : Itraconazole	PO : 200 mg/hari		EMPIRIS	24 jam	7 hari	Lini kedua
			Sistemik : Fluconazole	PO : 150-300 mg/hari		EMPIRIS	1 minggu	2 minggu	Lini kedua
6.	Dermatomikosis Malassezia folikulitis	<i>Malassezia furfur</i>	Topikal : Ketoconazole	Sampo 2%		EMPIRIS	24 jam, terapi rumatan : 2- 3x /minggu	2-4 minggu	Lini pertama
			Topikal : Seleniumsulfide	Sampo 2,5%		EMPIRIS	24 jam, selama 3 hari, terapi rumatan : 1 x/minggu	2-4 minggu	Lini pertama
			Sistemik : Ketoconazole	PO : 200 mg/hr		EMPIRIS	24 jam terapi rumatan:400 mg/minggu	2-4 minggu	Lini pertama
			Sistemik : Fluconazole	PO : 150 mg/hr		EMPIRIS	24 jam terapi rumatan:200 mg/bulan	2-4 minggu	Lini pertama
			Sistemik : Itraconazole	PO : 200 mg/hr		EMPIRIS	24 jam	1-3 minggu	Lini kedua
7.	Dermatomikosis Kandidiasiskutis	<i>Candida albicans</i>	Topikal : Ketoconazole	Krim 2% : 2 x sehari		EMPIRIS	12 jam	2-6 minggu	Lini pertama
			Topikal : Clotrimazole	Krim 2% : 2 x sehari		EMPIRIS	12 jam	2 minggu	Lini pertama

			Topikal : Miconazole	Krim 2% : 2 x sehari		EMPIRIS	12 jam	2 minggu	Lini pertama
			Sistemik : Ketoconazole	PO : 200 mg/hari		EMPIRIS	24 jam	2 minggu	Lini pertama
			Sistemik : Fluconazole	PO : 150 mg/hari		EMPIRIS	24 jam terapi rumatan:200 mg / bulan	2-4 minggu	Lini kedua
8.	Dermatomikosis Kandidiasisoral	<i>Candida albicans</i>	Troches : Clotrimazole	Troches 10 mg		EMPIRIS	5 jam	1-2 minggu	Lini pertama
			Miconazole tablet buccal	Tablet buccal 50 mg		EMPIRIS		1-2 minggu	Lini pertama
			Topikal : Nystatin Suspensi	Oral : 4-6 ml (400.000–600.000 I.U)		EMPIRIS	6 jam	1-2 minggu	Lini kedua
			Sistemik : Ketoconazole	PO : 200-400 mg/hari		EMPIRIS	24 jam	2-4 minggu	Lini pertama
			Sistemik : Fluconazole	PO : 100-200 mg/hari		EMPIRIS	24 jam / 3 x seminggu	1-2 minggu	Lini pertama
			Troches : Clotrimazole	Troches 10 mg		EMPIRIS	5 jam	1-2 minggu	Lini pertama
9.	Dermatomikosis Kandidiasis Vulvovaginalis	<i>Candida albicans</i>	Topikal : Mikonazole	Krim 2%		EMPIRIS	24 jam	7 hari	Oles intravagina
			Suppositoria : Nystatin Ovula	200.000 IU			24 jam	7 hari	Dosis tunggal
			Sistemik : Fluconazole	PO : 150 mg			Dosis tunggal	Dosis tunggal	Dosis tunggal
			Sistemik :						

			Itrakonazole				DT		
10.	Infeksi Bakteri Impetigo, Ektima	<i>Staphylococcus aureus</i>	Topikal : Mupirocin	Ointment 2%	Ointment 2%	EMPIRIS	Dewasa atau anak : 12 jam	5-7 hari	Lesi lokal
			Topikal : Asam fusidat	Krim 1%	Krim 1%	EMPIRIS	Dewasa atau anak : 6-12 jam	5-7 hari	Lesi lokal
			Sistemik : Dicloxacillin	PO : 250-500 mg	Tidak digunakan untuk anak	EMPIRIS	6 jam	7 hari tergantung klinis	Lini pertama
			Sistemik : Erythromycin	PO : 200-500 mg	PO : 30-50 mg/kg/hari (terbagi 3-4 dosis)	EMPIRIS	Dewasa : 6 jam Anak : 6-8 jam		Jika alergi Penisilin
			Sistemik : Amoxicilin/ clavulanic acid	PO : 875/125 mg	PO : 25 mg/kg/hari (terbagi 3 dosis)	EMPIRIS	Dewasa : 12 jam Anak : 8 jam		Lini pertama
			Sistemik : Clindamycin	PO : 300-450 mg	PO : 20-30 mg/kg/day (terbagi 3-4 dosis)	EMPIRIS	Dewasa : 6-8 jam Anak : 6-8 jam		Lini kedua
11.	Infeksi Bakteri Folikulitis	<i>Streptococcus pyogenes</i>	Topikal: Mupirocin	Krim 2%	Krim2%	EMPIRIS	12 jam	5-7 hari	Lini pertama
			Sistemik : Cloxacillin	PO : 250-500 mg	Tidak digunakan untuk anak	EMPIRIS	6 jam	7 hari	Lini pertama
			Sistemik : Erythromycin	PO : 250-500 mg	PO : 30-50 mg/kgBB/hari	EMPIRIS	6 jam	7-10 hari	Jika alergi Penisilin
12.	Infeksi Bakteri Eritrasma	<i>Corynebacterium minutissimum</i>	Topikal : Erythromycin	Solutio 2%	Solutio 2%	EMPIRIS	12 jam	7 hari	Lini pertama

			Topikal : Clindamycin	Solutio 2%	Solutio 2%	EMPIRIS	12 jam	7 hari	Lini pertama
			Sistemik : Erythromycin	PO : 250 mg	PO : 30-50 mg/kg/hari, terbagi 3-4 dosis	EMPIRIS	6 jam	14 hari	Lini pertama
			Sistemik : Clarithromycin	PO : 1 gram		EMPIRIS	-	Dosis tunggal	Lini kedua
13.	Infeksi Bakteri & Erisipelas Selulitis	• <i>Group A Streptococcus</i> • <i>S. Aureus group A</i> • <i>Streptococcus</i>	Sistemik : Cloxacillin	PO : 250-500 mg	Tidak digunakan untuk anak	EMPIRIS	6 jam	7 hari	
			Sistemik : Clindamycin	PO : 300-450 mg	PO : 20-30 mg/kg/day terbagi 3-4 dosis	EMPIRIS	6-8 jam	7 hari	Alergi penisilin Dosis anak usia > 1 bulan Purulent (Mild) MRSA Susp
			Sistemik : Dicloxacillin	PO : 2 x100 mg	PO : 2 mg/kg/day	EMPIRIS	12 jam	7 hari	Purulent (Mild) MRSA susp
			Sistemik: Ceftriaxone			EMPIRIS		7 hari	Purulent (Moderate) MSSA Susp
14.	Infeksi Varicella / Herpes zoster	<i>Varicella zoster virus</i>	Sistemik : Acyclovir	PO : 800 mg (≥ 40kg)	Neonatus : 10 mg/kg PO : 20 mg/kg (2 s/d <18tahun)	EMPIRIS	Dewasa : PO : 5 x 800 mg/ hari Anak : 6 jam Neonatus : 8 jam	2 s/d <18 tahun 5 hari Dewasa : 7-10 hari Neonatus : 10 hari	2 s/d < 18 tahun : dosis tidak lebih dari 3200 mg/hari
			Sistemik : Valacyclovir	PO : 1 gram	PO : 20 mg/kg	EMPIRIS	8 jam	Dewasa : 7 hari Anak : 5 hari	2 s/d <18 tahun : Dosis tidak lebih dari 3 g/hari

15.	Infeksi simplex	Herpes	<i>Herpes simplex virus (non genitalis)</i>	Sistemik : Acyclovir	PO : 200 mg / 400 mg		EMPIRIS	Dewasa : 5x200 mg/hari atau 3x400 mg/hari	7 hari	
				Sistemik : Valacyclovir	PO : 500 mg		EMPIRIS	12 jam	7 hari	
			<i>Herpes simplex virus (genitalis)</i>	Sistemik : Asiklovir	PO : 400 mg		EMPIRIS	8 jam	7-10 hari	
				Sistemik : Valasiklovir	PO : 1 g		EMPIRIS	12 jam	7-10 hari	
				Sistemik : Famsiklovir	PO : 250 mg		EMPIRIS	8 jam	7-10 hari	
16.	Infestasi Skabies	Parasit	<i>Sarcoptes scabiei var hominis</i>	Topikal : Permetrin 5%	Krim 5%		EMPIRIS		8-14 jam tidak boleh terkena air, diulang 7 hari kemudian	Wanita hamil, ibu menyusui, dan anak < 2 tahun menggunakan dengan jarak 1 minggu (2 kali interval), dan hanya 2 jam penggunaan.
				Topikal : Sulfur presipitatum 5%– 10%	Krim 5-10%	Krim 5-10%	EMPIRIS		Dioleskan selama 8 jam pada hari ke- 1,2,3	Aman untuk anak < 2 bulan, neonatus, dan ibu hamil.
17.	Gonorrhoeae (cervicitis/ urethritis)		<i>Neisseria gonorrhoeae</i>	Sistemik : Ceftriaxone	IM : 500 mg		EMPIRIS		Dosis tunggal	
				Sistemik : Gentamicin	IM : 240 mg		EMPIRIS		Dosis tunggal	

			Sistemik : Azitromisin	PO : 2 g		EMPIRIS		Dosis tunggal	
			Sistemik : Cefixime	PO : 800 mg		EMPIRIS		Dosis tunggal	
18.	Urethritis gonococcal non	<i>Chlamidia trachomatis</i>	Sistemik : Doxycycline	PO : 100 mg		EMPIRIS	12 jam	7 hari	
			Sistemik : Azithromycin	PO : 1 gram		EMPIRIS		Dosis tunggal	
			Sistemik : Levofloxacin	PO : 500 mg		EMPIRIS	24 jam	7 hari	
19.	Cervicitis gonococcal non	<i>Chlamidia trachomatis</i>	Sistemik : Doxycycline	PO : 100 mg		EMPIRIS	12 jam	7 hari	
			Sistemik : Azithromycin	PO : 1 gram		EMPIRIS		Dosis tunggal	
			Sistemik : Levofloxacin	PO : 500 mg		EMPIRIS	24 jam	7 hari	
20.	Ophtalmia neonatorum	<i>Chlamidia trachomatis</i>	Sistemik : Erythromycin base atau Erythromycinethyl		PO : 50 mg/kg/hari	EMPIRIS	6 jam	14 hari	
21.	Bakterial vaginosis	<i>Gardnerella vaginalis</i>	Sistemik : Metronidazol	PO : 500 mg		EMPIRIS	12 jam	7 hari	
			Klindamisin	PO : 300 mg		EMPIRIS	12 jam	7 hari	
22.	Kandidiasis vulvovaginalis (<i>uncomplicated</i>)	<i>Candida spp</i>	Topikal : Mikonazol	Krim 2%		EMPIRIS	24 jam	7 hari	Oles intravagina

			Suppositoria : Nystatin Ovula	100.000 IU		EMPIRIS	24 jam	14 hari	
			Sistemik : Fluconazole	PO : 150 mg		EMPIRIS		Dosis tunggal	
23.	Ulkus mole (chancroid)	<i>Haemophilus ducreyi</i>	Sistemik : Azithromycin	PO : 1 gram		EMPIRIS		Dosis tunggal	
			Sistemik : Ceftriaxone	IM : 250 mg		EMPIRIS		Dosis tunggal	
			Sistemik : Ciprofloxacin	PO : 500 mg		EMPIRIS	12 jam	3 hari	
			Eritromycin base	PO : 500 mg		EMPIRIS	8 jam	7 hari	
24.	Sifilis stadium primer / sekunder / laten dini	<i>Treponema pallidum</i>	Sistemik : Benzatin Penicilline	IM : 2.4 juta IU		EMPIRIS		Dosis tunggal	Dosis tunggal
	Sifilis stadium laten lanjut / Sifilis tersier	<i>Treponema pallidum</i>	Sistemik : Benzatin Penicilline	IM : 2.4 juta IU		EMPIRIS	1 minggu	3 minggu	(3x suntik)
	Sifilis kongenital (confirmed or highly probable)	<i>Treponema pallidum</i>	Sistemik : Aqueous crystalline penicillin G		IV : 50.000/unit/kgBB dilanjutkan 50.000/unit/kgBB	EMPIRIS	12 jam dilanjutkan 8 jam	7 hari pertama kehidupan dilanjutkan 3 hari setelahnya	Total : (10 x suntik, 7 hari pertama interval 12 jam, 3 hari selanjutnya interval 8 jam)
			Sistemik : Procaine Penicillin		IM : 50.000unit/KgBB/ hari	EMPIRIS	24 jam	10 hari	(10 x suntik)
	Sifilis kongenital (possible)	<i>Treponema pallidum</i>	Sistemik : Aqueous crystalline penicillin G	IV : 50.000/unit/kgBB dilanjutkan 50.000/unit/kgBB		EMPIRIS	12 jam dilanjutkan 8 jam	7 hari pertama kehidupan dilanjutkan 3 hari setelahnya	Total : (10 x suntik, 7 hari pertama interval 12 jam, 3 hari selanjutnya interval 8 jam)

									interval 8 jam)
			Sistemik : Procaine Penicillin G	IM : 50.000 unit/KgBB/hari		EMPIRIS	24 jam	10 hari	(10 x suntik)
			Sistemik : Benzathine Penicillin G	IM : 50.000 unit/KgBB/hari		EMPIRIS		Dosis tunggal	Dosis tunggal

3.13 SMF Ilmu Penyakit Dalam

No	Keadaan klinik/ penyakit/tindakan	Kuman penyebab	Rekomendasi antimikroba	Dosis		Empiris / profilaksis	Interval	Lama pemberian	Keterangan
				Dewasa	Anak				
1.	Diare	Shigella spp	1. Ciprofloxacin	PO : 500 mg IV : 400 mg		EMPIRIS	12 jam	3 hari	Bila pasien muntah / ada tanda sepsis, antibiotic diberikan secara IV. pasien imunokompromais diberikan antara 7-10 hari
			2. Cotrimoxazole	PO : 960 mg		EMPIRIS	12 jam	5 hari diberikan bila MRS	
		Salmonella Thypii	1. Ciprofloxacin	PO : 500 mg IV : 400 mg		EMPIRIS	12 jam	3-5 hari	
			2. Chlorampenicol	PO : 500 mg IV : 500 mg		EMPIRIS	6 jam	10-14 hari	
		Vibrio cholera	1.Tetracycline	PO : 500 mg IV : 500 mg		EMPIRIS	6 jam	3 hari	
			2. Ciprofloxacin	PO : 500 mg IV : 400 mg		EMPIRIS	12 jam	3-5 hari	
		Clostridiumdifficile	Metronidazole	PO : 500 mg IV : 500 mg		EMPIRIS	6-8 jam	7-14 hari	
		Giardia Lambia	Metronidazole	PO : 500 mg IV : 500 mg		EMPIRIS	6 jam	7-14 hari	
		Entamoeba Hystolitica	Metronidazole	PO : 500 mg IV : 500 mg		EMPIRIS	6 jam	7-14 hari	
		Isosporabelii	Cotrimoxazole	PO : 960 mg		EMPIRIS	12 jam	7-10 hari	
		Cryptosporidia	Paromomisin + Azithromycin	PO : 4 gr/hari + PO : 500 mg		EMPIRIS	24 jam	4 hari	
		Salmonella (non typhoidal)	1. Ciprofloxacin	PO : 500 mg IV : 400 mg		EMPIRIS	12 jam	3 hari	
			2. Cotrimoxazole	PO : 960 mg		EMPIRIS	12 jam	3 hari	
2.	Traveler diarea	E.coli Cyclospora cayetanensis Isosporabelli	Ciprofloxacin	PO : 500 mg IV : 400 mg		EMPIRIS	12 jam	1-5 hari	

3.	Infeksi H.pylori	Helicobacter pylori	Clarithromycin + Amoxycillin	PO : 500 mg + PO : 1 gram		EMPIRIS	12 jam 12 jam	7-14 hari	Dengan penambahan terapi lansoprasol 30 mg tiap 12 jam selama 14 hari
			Tetrasiklin + Metronidazole + Bismutsubsalisilat	PO : 250 mg + PO : 500 mg + PO : 2 tab		EMPIRIS	6 jam 8 jam 12 jam	7-14 hari	Di daerah yang diketahui resisten klaritromisin > 20 % dengan penambahan terapi lansoprasol 30 mg tiap 12 jam selama 14 hari
4.	Kolesistitis akut	Entero bacterial family Enterococcus / anaerob	Cefotaxime	IV : 1 gram		EMPIRIS	12 jam	7 hari	Antibiotik diberikan bila ada tandain feksi leukositosis suhu lebih dari 35°C dan gambaran udara pada dinding atau kantung empedu)
			Cefotaxime +	IV : 1 gram		EMPIRIS	12 jam	7 hari	
			Ciprofloxacin	IV : 200 mg		EMPIRIS	12 jam	7 hari	
		Clostridium perfringens	Metronidazole	IV : 500 mg		EMPIRIS	6 jam	7 hari	
5.	Sirosis dengan Spontaneous peritonitis bakteria	Escherichia coli Klebsiella pneumonia Non-enterococcal - Streptococcus spp	Ceftriaxone	IV : 1 gram		EMPIRIS	12-24 jam	10-14 hari	
6.	Candidiasis Mucocutaneus candidiasis: Cutaneus Vulvovaginal Thrush esophageal invasi.ve (kidney, GI tract, urinarytract, abdomen)	Candida glabrata Candida albicans Candida Sp.	Fluconazole	PO : 150 mg IV : 200 mg		EMPIRIS	24 jam	14 hari	
			Micafungin	IV : 100 mg		EMPIRIS	24 jam	14 hari	Bila terjadi resistensi fluconazol atau telah menggunakan fluconazol 7 hari tapi tidak ada perbaikan
7.	Influenza A	H1N1	Oseltamir	PO : 75 mg PO : 75 mg		EMPIRIS	12 jam 24 jam	5 hari 10 hari	
8.	Difteri	Corynebacterium diptheriae	ADS +			EMPIRIS			ADS 40.000 U (nasal / faucial diptheria)

									ADS 60.000 U (moderate nasofaringeal / faucial diptheria)
									ADS 100.000 U (systemic / severe diptheria, bullneck dyphtheria atau diptheri > 3 hr)
			1. Penicillin Procaine	IM : 1.200.000 unit/hari		EMPIRIS	12 jam	14 hari	
			2. Erithromycin	PO : 2 gram/hari		EMPIRIS	6 jam	14 hari	
9.	Selulitis Wajah/ Leher	Streptokokus sp	1. Clindamycin	PO : 150-300 mg		EMPIRIS	6-12 jam	5-7 hari	Regimen IV diberikan pada kasus berat yang membutuhkan rawat inap
			2. Cloxacilin	IV/IM : 1000 mg		EMPIRIS	8 jam	5-7 hari	
10.	Uncomplicated UTI (Cystitis)	E. Coli (80%)	Levofloxacin	PO : 750 mg		EMPIRIS	24 jam	3-5 hari	Diabetes, Pregnancy, usia > 65 tahun : 7-10 hari
		Klebsiella	Ciprofloxacin	PO : 500 mg		EMPIRIS	12 jam	5-7 hari	
		Enterobacter	Cotrimoxazole	PO : 960 mg		EMPIRIS	12 jam	5-7 hari	Tidak untuk enerococcus dan pseudomonas)
		Pseudomonas	Ciprofloxacin	PO : 500 mg		EMPIRIS	12 jam	7 hari	
		Staphylococcus Saprophyticus (5-15%)	Cotrimoxazole	PO : 960 mg		EMPIRIS	12 jam	5-7 hari	
11.	Complicated UTI Acute pyelonephritis non rawat inap	E. Coli (80%)	Levofloxacin	IV : 750 mg		EMPIRIS	24 jam	3-5 hari	Diabetes, Pregnancy, usia > 65 tahun : 7-10 hari
		Klebsiella	Ciprofloxacin	IV : 500 mg		EMPIRIS	12 jam	5-7 hari	
		Enterobacter	Cotrimoxazole	PO : 960 mg		EMPIRIS	12 jam	14 hari	Tidak untuk enerococcus dan pseudomonas)
		Pseudomonas	Ciprofloxacin	PO : 500 mg IV : 400 mg		EMPIRIS	12 jam	7 hari	
		Staphylococcus Saprophyticus (5-15%)	Cotrimoxazole	PO : 960 mg		EMPIRIS	12 jam	5-7 hari	
12.		E. Coli	Cefepime	IV : 1000 mg		EMPIRIS	12 jam		

	Complicated UTI Kasus rawat inap Kasus berat C. Perirenal atau pararenal abses	Klebsiella	Gentamicin	IV : 160-240 mg		EMPIRIS	24 jam	Ganti oral setelah 48 jam klinis membaik	
		Enterobacter	Ampicillin	IV : 1000 mg		EMPIRIS	6 jam		
		Pseudomonas	Ceftriaxone	IV : 1000 gram		EMPIRIS	12 jam		
		Staphylococcus Saprophyticus (5- 15%) Acinetobacter baumannii Proteus mirabilis	Cefoperazone Sulbactam	IV : 1,5 gram		EMPIRIS	12 jam		
13.	Epididymitis	E.Coli Klebsiella Enterobacter Pseudomonas Staphylococcus Saprophyticus (5- 15%)	Cotrimoxazole	PO : 960 mg		EMPIRIS	12 jam	3 minggu	
			Ciprofloxacin	PO : 500 mg IV : 400 mg		EMPIRIS	12 jam	3 minggu	
14.	Acute Bacterial Prostatitis	E.Coli Klebsiella Enterobacter Pseudomonas Staphylococcus Saprophyticus (5- 15%)	Cotrimoxazole	PO : 960 mg		EMPIRIS	12 jam	4 minggu	
			Ciprofloxacin	PO : 500 mg IV : 400 mg		EMPIRIS	12 jam	4 minggu	
15.	Uncomplicated Intravascular Catheter Related Infection/ Remove catheter	Staphylococcus coagulase (-) Staphylococcus aureus Enterococcus Gram (-) Bacili Candida spp	Amoxicillin Clavulanic Acid	650 mg		EMPIRIS	6-8 jam	5-7 hari	
			Ampicillin Sulbactam	1.5 gram		EMPIRIS	6 jam	7-14 hari	
			Cefoperazon Sulbactam	1 gram		EMPIRIS	12 jam	7-14 hari	
			Fluconazole	400-600 mg		EMPIRIS	24 jam	14 hari (adjusting sesuai fungsi renal)	
16.	Complicated Intravascular Catheter Related Infection	Staphylococcus coagulase (-)	Amoxicillin Clavulanic Acid	650 mg		EMPIRIS	8 jam	7 hari	
		Staphylococcus aureus	Ampicillin Sulbactam	IV : 1,5gram		EMPIRIS	6 jam	7 hari	

		Enterococcus	Cefoperazone Sulbactam	1,5gram		EMPIRIS	12 jam	7 hari	
		Candida spp	Fluconazole	400 - 600mg		EMPIRIS	24 jam	14 hari (adjusting sesuai fungsi renal)	
17.	Typhoid fever	Salmonella typhosa	1. Ciprofloxacin atau Ceftriaxon	PO/IVFD : 500mg IV : 1 gram		EMPIRIS	12 jam	5-7 hari	
			2. Chloramphenicol	PO/IV : 500 mg		EMPIRIS	24 jam	5-7 hari	
18.	Tetanus	Clostridium tetani	Metronidazole	PO/IVFD : 500 mg		EMPIRIS	6 jam	7 hari	Apabila TIG tidak tersedia, dapat diberikan ATS 10.000-20.000 Unit equine IM dosis tunggal
19.	Neutropenia Paska Kemoterapi	Staphylococcus aureus	Ciprofloxacin	PO : 500 mg atau IV : 200 mg		PROFILAKSIS	12 jam	5-7 hari	Diberikan bila Neutrofil < 1.500
		Haemophilus influenza	Amoxicillin-Clavulanic Acid	625 mg		PROFILAKSIS	8 jam		
		Klebsiella pneumonia	Cotrimoxazole	960 mg		PROFILAKSIS	12 jam		
		Eschericia Coli							
20.	Sepsis (fokus infeksi belum diketahui)		Ampicillin + Gentamicin	IV : 1000 mg IV : 160 mg		EMPIRIS	6 jam + 24 jam	7-10 hari	Antibiotika diubah sesuai dengan hasil kultur dan test kepekaan
			Ampicillin + Gentamicin + Metronidazol	IV : 1000 mg IV : 160 mg IV : 500 mg		EMPIRIS	6 jam + 24 jam + 6 jam	7-10 hari	Antibiotika diubah sesuai dengan hasil kultur dan test kepekaan
			Ceftriaxon + Levofloxacin	IV : 1000 mg IV : 750 mg		EMPIRIS	8 jam + 24 jam	7-10 hari	Antibiotika diubah sesuai dengan hasil kultur dan test kepekaan
			Cefoperazone Sulbactam	IV : 1500 mg		EMPIRIS	12 jam	7-10 hari	Antibiotika diubah sesuai dengan hasil kultur dan test kepekaan

BAB IV. PENUTUP

Demikian Panduan Penggunaan Antibiotik Rumah Sakit Prima Husada dibuat. Semoga dengan adanya pembaruan PPAB ini dapat dijadikan sebagai acuan serta evaluasi pemberian antibiotik yang rasional.

BAB V
CARA PENGGUNAAN ANTIMIKROBA

5.1 Rekonstitusi dan Pelarutan Sediaan Injeksi Antimikroba

Tabel 2 Rekonstitusi Antibiotik

No	Nama Obat	Rute	Rekonstitusi	Stabilitas dalam penyimpanan		Keterangan
				2-8 ⁰ C	15-25 ⁰ C	
1.	Amikasin inj 250 mg/2 ml (Mikaject)	IV drip	Di encerkan dengan 100 - 200 ml NaCl 0,9%	60 hari	24 jam	- Larutan amikasin dalam air dapat mengalami penggelapan warna karena oksidasi udara, namun perubahan warna ini tidak mempengaruhi potensi. - Bisa diberikan secara IM atau IV. Waktu pemberian IV drip pada orang dewasa atau anak-anak lamanya antara 30 menit – 1 jam dan pada bayi lamanya antara 1-2 jam. - Infus yang dapat digunakan D5%, NS, RL, D5/NS, D51/2NS.
2.	Ampicilin Sulbactam inj (Bactesyn)					- Dapat diinjeksikan secara IV pelan langsung 10 –15 menit. - Larutan yang sudah direkonstitusi tidak bisa disimpan karena dapat mengakibatkan penurunan potensi.
	0,75 gr (mengandung Ampicillin 0,5 gram + Sulbactam 0,25 gr)	IV	Tambahkan 1,6 ml Water for Injection (mengandung ampicilin 250 mg/ml dan sulbactam 125 mg/ml)	48 jam	8 jam	
	1,5 gr (mengandung Ampicillin 1 gram + Sulbactam 0,5 gr)		Tambahkan 3,2 ml Water for Injection (mengandung ampicilin 500 mg/ml dan sulbactam 250 mg/ml)	48 jam	8 jam	
		IV Drip	Diencerkan dengan 50-100 ml NaCl 0,9% dengan lama pemberian 15 – 30 menit	-	8 jam	
3.	Ampicillin Sulbactam inj (Picyn)					Harus di rekonstitusi dengan WFI atau

	0,75 gr (mengandung Ampicillin 0,5 gram + Sulbactam 0,25 gr)	IV	Tambahkan 1,6 ml Water for Injection (mengandung ampicilin 250 mg/ml dan sulbactam 125 mg/ml)	24 jam	1 jam	Larutan lain yang kompatibel yang dapat menghilangkan busa untuk larut sempurna. - Dosis dapat diberikan melalui injeksi bolus selama minimum 3 menit. - Dosis dapat diberikan sebagai infus IV selama 15-30 menit. Dapat diberikan melalui injeksi IM; jika rasa sakit dialami, larutan steril untuk injeksi Lidocain HCl anhydrate 0.5% dapat digunakan untuk rekonstitusi serbuk
	1,5 gr (mengandung Ampicillin 1 gram + Sulbactam 0,5 gr)		Tambahkan 3,2 ml Water for Injection (mengandung ampicilin 500 mg/ml dan sulbactam 250 mg/ml)	24 jam	1 jam	
		IV drip	Dilarutkan dengan 50-100 ml Water for Injection atau NaCl 0.9% selama 15-30 menit pemberian.	48 jam	8 jam	
			Dilarutkan dengan 50-100 ml Dextrose 5% selama 15-30 menit pemberian.	4 jam	2 jam	
			Dilarutkan dengan 50-100 ml Ringer Lactate selama 15-30 menit.	24 jam	8 jam	
	0,75 gr (mengandung Ampicillin 0,5 gram + Sulbactam 0,25 gr)	IM	Dilarutkan dalam 1,6 ml Lidocain HCl anhidrat 0,5%	-	8 jam	
	1,5 gr (mengandung Ampicillin 1 gr + Sulbactam 0,5 gr)		Dilarutkan dalam 3,2 ml Lidocain HCl anhidrat 0,5%	-	8 jam	
4.	Azithromycin 500 mg	IV drip	Dilarutkan dalam 4,8 ml WFI kemudian larutan tersebut diencerkan ke NaCl 0,9% 500 ml atau D5%	7 hari	24 jam	Diberikan infus intravena tidak lebih dari 60 menit. Jangan diberikan sebagai bolus intravena atau injeksi intramuscular (i.m)
5.	Benzatin Benzil Penicillin 1,2 IU	IV	Dilarutkan dalam 4 ml aqua pro injeksi ke dalam vial secara pelan pelan dan homogenkan (jangan dikocok keras, cukup kocok pelan sampai homogen)	24 jam	24 jam	Aspirasi ke dalam spuit secara perlahan (aspirasi dengan cepat ke dalam spuit mengakibatkan bloking pada jarum karena konsentrasi material tersuspensi besar)
6.	Cefotaxime					Perubahan warna serbuk/ larutan

	1 gram	IV	Tambahkan 10 ml aqua pro inj (konsentrasi 100 mg/ml), kemudian diinjeksikan selama 3-5 menit	7 hari	24 jam	menjadi gelap, tidak boleh digunakan lagi karena potensinya hilang. • Simpan ditempat terlindung dari cahaya matahari. • Pemberian IM diinjeksikan dalam gluteus maximus, sebaiknya tidak lebih dari 4 ml pada tiap sisi. Rasa sakit dapat dihindarkan dengan melarutkan dalam larutan Lidokain 1% (namun penyediaan larutan injeksi harus dibuat baru).
		IV Infus	Tambahkan 50 -100 ml NaCl 0.9% atau D5%, kemudian diinfuskan selama 20 - 60 menit	7 hari	24 jam	
		IM	Tambahkan 3 ml aqua pro inj	-	24 jam	
7.	Ceftriaxone atau Rixone					• Setelah direkonstitusi larutan berwarna kekuningan. • Injeksi IV selama 2-4 menit
	250 mg	IV	Ditambahkan 2,5 ml aqua pro injeksi	1 hari	6 jam	
	500 mg	IV	Ditambahkan 5 ml aqua pro injeksi	1 hari	6 jam	
	1 gram	IV	Ditambahkan 10 ml aqua pro injeksi	1 hari	6 jam	
8.	Ceftazidime					• Injeksi IV langsung 3-5 menit • Dalam penyimpanan dapat terjadi perubahan warna menjadi gelap, namun masih dapat digunakan karena tidak ada perubahan potensi
	0,5 gram	IV	Tambahkan 5 ml aqua pro inj (konsentrasi 100 mg/ml)	7 hari	18 jam	
	1 gram	IV	Tambahkan 10 ml aqua pro inj (konsentrasi 100 mg/ml)	7 hari	18 jam	
9.	Ceftizoxime (tiap vial mengandung ceftizoxime sodium yang setara dengan ceftizoxime 1000 mg)	IV	Injeksi : Direkonstitusi dengan 10 ml aqua pro injeksi, larutan garam (NaCl) atau larutan glukosa.	-	Maksimal 24 jam	Infus : Larutan Ceftizoxime yang telah direkontitusi ke dalam 50 – 100 mL pelarut yang kompatibel (Larutan NaCl 0,9%; 5 atau 10% dekstrosa; 5% dekstrosa dan 0,2%, 0,45% atau 0,9% NaCl; Larutan Ringer Laktat, atau Larutan Natrium Bicarbonat 5%.
		IM	Direkonstitusi dengan 3 ml aqua pro injeksi.	-	Maksimal 16 jam	
10.	Cefuroxime Sodium 750 mg	IM	750 mg cefuroxime dilarutkan dalam 3 ml WFI, kocok dengan hati-hati untuk menghasilkan suatu suspense yang opaque	24 jam	5 jam	Cefuroxime sebaiknya tidak dicampur dalam satu syringe dengan antibiotika aminoglycoside.

		IV	750 mg Cefuroxime dilarutkan dalam 6 ml WFI.	24 jam	5 jam	
		Infus IV	Dilarutkan dalam 25 ml WFI, infus NaCl 0.9% atau infus D10%	-	24 jam	
11.	Cefoperazone-Sulbactam					• Injeksi IV diberikan dalam waktu minimal 3 menit • IV drip diberikan selama 15 – 60 menit
	1 gram (mengandung Cefoperazone 0,5 gr + Sulbactam 0,5 gram)	IV	Tambahkan 3,4 ml aqua pro inj	7 hari	24 jam	
		IV drip	Setiap vial Cefoperazone - Sulbactam dilarutkan dengan 3,4 ml dari D5% dalam air atau NaCl 0,9% dan kemudian diencerkan sampai 20 ml dengan larutan yang sama	7 hari	24 jam	
	2 gram	IV	Tambahkan 6,8 ml aqua pro inj			
12.	Cefoperazone Sodium 1 gram	IV	-Serbuk injeksi dilarutkan dahulu dalam 2,8-5 ml WFI per gram Cefoperazone sodium. Kocok hingga larut lalu biarkan sampai busa larutan menghilang. -Larutan yang dihasilkan harus diencerkan lebih lanjut menggunakan pembawa untuk infus IV : D5%, RL, D5%+NaCl 0,9%, D10%, NaCl 0,9 %.	5 hari	24 jam	• Pelarut untuk rekonstitusi awal : D5%, D5%+NaCl 0,9%, NaCl 0,9%, WFI • Injeksi IV langsung, dosis maksimal untuk orang dewasa 2 gram setiap kali pemberian. Disuntikkan antara 3-5 menit
		Infus IV intermittent	-Setiap 1-2 gram Cefoperazone dilarutkan dalam 20 ml WFI dan			

			disuntikkan selama 15 menit sampai 1 jam.			
		Infus IV Contino us	-Setiap gr Cefoperazone, dilarutkan dalam 5 ml WFI.			
		IM	-Konsentrasi akhir cefoperazone 250 mg/ml : Tambahkan 2,8 ml WFI, kocok hingga larut. Kemudian tambahkan 1 ml Lidokain 2%. -Konsentrasi akhir cefoperazone 333 mg /ml : Tambahkan 2 ml WFI, kocok hingga larut. Kemudian tambahkan 0,6 ml Lidokain 2%.			
13.	Cefazoline 1 gram	IV / IM	1000 mg Cefazolin ditambahkan 2,5 ml WFI, kocok dengan baik sampai terlarut.	14 hari	48 jam	• Larutkan vial rekonstitusi dalam 5 ml WFI untuk injeksi (iv bolus) • Suntikkan secara perlahan selama 3 sampai 5 menit
		IV drip	Larutkan cefazolin yang telah di rekonstitusi ke dalam 50 ml atau 100 ml cairan infus NaCl 0.9%, 10% dextrose, RL, atau D10%.	-	24 jam	Pada Pemberian infus berselang atau terus- menerus
14.	Fluconazole Infus larutan 200 mg/100 ml	IV drip	-	-	Harus segera digunakan	• Tidak boleh digunakan bila larutan keruh dan ada endapan • Larutan tidak boleh dibekukan • Kecepatan pemberian drip minimal 1 jam/100 ml
15.	Gentamicin inj larutan 80 mg/2 ml	IM, IV drip	Dilarutkan dalam 50 - 200 ml NaCl 0.9% atau D5%	-	Harus segera	• Larutan diinfuskan selama periode 1.5 - 2 jam.

			(pada bayi dan anak- anak volume pelarut lebih sedikit).		digunakan	Larutan tidak boleh dibekukan.
16.	Meropenem 1 gram					- IV bolus pelan selama 3 - 5 menit atau IV drip selama 15 – 30 menit - Tidak boleh digunakan jika larutan berubah warna menjadi kuning
		IV	Tambahkan 20 ml aqua pro inj	48 jam	8 jam	
	IV drip	Larutkan dalam 100 ml NaCl 0,9%	18 jam	2 jam		
		Larutkan dalam 100 ml D5%	8 jam	1 jam		
17.	Metronidazole infus 500 mg/100 ml	IV drip	-	-	Harus segera digunakan	- Infus diberikan dalam waktu lebih dari 1 Jam - Lindungi dari sinar matahari dan cahaya langsung karena dapat menyebabkan perubahan warna menjadi gelap
18.	Streptomycin					-
	200 mg/ml	IM	Dilarutkan dalam 4,2 ml WFI	-	24 jam	
	250 mg/ml	IM	Dilarutkan dalam 3,2 ml WFI			
	400 mg/ml	IM	Dilarutkan dalam 1,8 ml WFI			

Keterangan :

Cara pemberian sediaan injeksi (rute)

IM : intramuscular

IV : intravena

IVFD : intravena fluid drip

Injeksi intravena dapat diberikan dengan berbagai cara, untuk jangka waktu yang pendek atau untuk waktu yang lama :

- Injeksi bolus
Injeksi dengan volume kecil, biasanya diberikan dalam waktu 3-5 menit kecuali ditentukan lain untuk obat-obatan tertentu.
- Infus
Infus dapat diberikan secara singkat (*intermittent*) atau terus-menerus (*continuous*).
- Infus singkat (intermittent infusion)
Infus singkat diberikan selama 10 menit atau lebih lama. Waktu pemberiaan infus singkat sesungguhnya jarang lebih dari 6 jam per dosis.

d. Infus kontinu (continuous infusion)

Infus kontinu diberikan selama 24 jam. Volume infus dapat beragam mulai dari volume infus kecil diberikan secara subkutan dengan pompa suntik (syringe pump), misalnya 1 ml per jam, hingga 3 liter atau lebih selama 24 jam, misalnya nutrisi parenteral

BAB VI CATATAN KHUSUS

6.1 Kategori Antimikroba Pada Kehamilan

- a. Kategori A : Pada studi terkontrol pada wanita gagal menunjukkan resiko pada janin pada trimester 1, dan tidak ada bukti resiko pada trimester selanjutnya. Kemungkinan bahaya pada janin sedikit.
- b. Kategori B : dari hasil studi reproduksi pada hewan tidak menunjukkan resiko pada janin, tetapi tidak ada studi terkontrol pada ibu hamil; atau studi pada reproduksi hewan menunjukkan efek samping (penurunan fertilitas) yang tidak terkonfirmasi pada studi terkontrol pada trimester pertama wanita (dan tidak ada bukti pada resiko trimester selanjutnya).
- c. Kategori C : studi pada hewan menampakkan adanya efek samping pada janin (embryogenic, teratogenic, atau lainnya), dan tidak ada studi terkontrol pada wanita, atau studi pada wanita dan hewan tidak tersedia. Obat hanya diberikan jika potensial manfaat lebih besar daripada resiko pada janin.
- d. Kategori D : terjadi resiko pada janin, tetapi manfaat pemberian pada ibu hamil mungkin lebih diterima meskipun resikonya (misal, obat dibutuhkan dalam situasi menyelamatkan nyawa atau untuk penyakit yang serius dimana obat yang lebih aman tidak dapat digunakan atau tidak efektif).
- e. Kategori X : studi pada hewan atau manusia menunjukkan ketidaknormalan pada janin, ada bukti resiko pada janin berdasarkan pengalaman, atau keduanya; dan resiko penggunaan obai ini pada wanita hamil jelas lebih banyak daripada manfaatnya. Obat dikontraindikasikan pada wanita yang mungkin akan hamil.

Tabel 3 Daftar Keamanan Obat Antimikroba Pada Kehamilan

Nama Antimikroba	Kategori Kehamilan	Nama Antimikroba	Kategori Kehamilan	Nama Antimikroba	Kategori Kehamilan
Acyclovir	B	Ganciclovir	C	Streptomycin	D
Amikasin	D	Gentamisin	D	Sulfadiazine	B
Amoxicillin	B	Imipenem/Cilastatin	C	Sulfisoxazole	C
Amphotericin B	B	Isoniazid	C	Tetracycline	D
Ampicillin	B	Itraconazole	C	Tigecycline	D
Ampicillin/ Sulbactam	B	Ketoconazole	C	Tobramycin	D
Azitromisin	B	Lamivudine	C	Trimethoprim	C
Benzyl Penisilin	B	Levofloksasin	C	TMP/SMX	C

Cefazolin	B	Lopinavir/ritonavir	C	Vancomycin	C
Cefixime	B	Meropenem	B	Zidovudine	C
Ceftazidime	B	Metronidazole	B		
Ceftriaxone	B	Natamycin	C		
Cefuroxime	B	Nevirapin	C		
Chloramphenicol	C	Netilmicin	D		
Ciprofloxacin	C	Neomycin	D		
Clarithromycin	B	Norfloxacin	C		
Clavunilate	B	Ofloxacin	C		
Clindamycin	B	Oxacillin	B		
Colistin	C	Penicillin G	B		
Doxycycline	D	Piperacillin/tazobactam	B		
Doripenem	C	Polimiksin B	B		
Erythromycin	B	Ribavirin	X		
Ethambutol	B	Rimantadine	C		
Fluconazole	C	Ritonavir	B		
Foscarnet	C	Spiramycin	B		
Fosfomycin	B	Stavudine	C		

6.2 Penyesuaian Dosis Pada Gangguan Ginjal

Tabel 4 Penyesuaian Dosis Pada Gangguan Ginjal

Antibiotik	Waktu paruh (jam)		Dosis (fungsi ginjal normal)	Dosis berdasarkan CrCl (ml/min)		
	Normal	ESRD		>50 – 90	10-50	<10
Golongan Aminoglikosida						
Amikacin	1.4 – 2.3	17–150	7.5 mg/kg/12 jam atau 15 mg/kg/hari	7.5 mg/kg/12 jam	7.5 mg/kg /24 jam	7.5 mg/kg /48 jam
Tobramycin	2–3	20–60	1.7 mg/kg/8 jam	100 % /8 jam	100 % /12-24 jam	100 % /48 jam
Netilmicin	2–3	35–72	2.0 mg/kg/8 jam	100 % /8 jam	100 % /12-24 jam	100 % /48 jam
Streptomycin	2–3	30–80	15 mg/kg (max. of 1.0 g) /24 jam.	Tiap 24 jam	tiap 24–72 jam	Tiap 72–96 jam
Golongan Karbapenem						
Meropenem	1	6–8	1.0 g/8 jam	1.0 g /8 jam	1.0 g /12 jam	0.5 g /24 jam
Golongan Sefalosporin						
Cefazolin	1.9	40–70	1.0–2.0 g/8 jam	/8 jam	/12 jam	/24–48 jam
Cefepime	2.2	18	2.0 g/8 jam (max. dosis)	2 g/8 jam	2 g/12–24 jam	1 g/24 jam
Cefotaxime Ceftizoxime	1.7	15–35	2.0 g/8 jam	/8–12 jam	/12–24 jam	/24 jam
Ceftazidime	1.2	13–25	2 g/8 jam	/8–12 jam	/12–24 jam	/24-48 jam
Cefuroxime sodium	1.2	17	0.75–1.5 g/ 8 jam	/8 jam	/8–12 jam	/24 jam
Golongan Floroquinolon						
Ciprofloxacin	3 6	6–9	500 – 750 mg po (atau 400 mg IV) /12 jam	100%	50–75 % 400 mg IV / 24 jam	50%
Levofloxacin / D&I	6–8	76	750 mg/24 jam i.v, p.o	750 mg /24 jam	20-49: 750 / 48 jam	<20: 750 mg/ 24 jam, kemudian 500 mg/ 48

						jam
Golongan Makrolida						
Clarithromycin	5–7	22	0.5–1.0 g/12 jam	100 %	75 %	50–75 %
Erythromycin	1.4	5–6	250–500 mg/6 jam	100 %	100 %	50–75 %
Golongan Penisilin						
Amoxicillin	1	5–20	250–500 mg/8 jam 250 mg–2 g/ 6 jam	/8 jam	/8–12 jam	/24 jam
Ampicillin	1	7–20		/6 jam	/6–12 jam	/12–24 jam
Amoxicillin/ Clavulanate	1.3 AM 5–20	1 4	500/125 mg/8 jam	500/125 mg/8 jam	250–500 mg AM component / 12	250–500 mg AM component / 24
Aztreonam	2	6–8	2 gm/8 jam	100%	50–75%	25%
Penicillin G	0.5	6–20	0.5–4 million U /4 jam	100%	75%	20–50%
Golongan Tetrasiklin						
Tetracycline	6–10	57–108	250–500 mg/6 jam	/8–12 jam	/12–24 jam	/24 jam
Golongan Miscellaneous						
Colistin	<6	≥48	80–160 mg/8 jam	160 mg /8 jam	160 mg /24 jam dosis sama untuk CRRT	160 mg/36 jam
Daptomycin	9,4	30	4–6 mg/kg perhari	4–6 mg per kg perhari	CrCl<30, 4–6 mg per kg /48 jam	
Linezolid	5,6	6,8	600 mg Po/IV /12 jam	600 mg /12 jam	600 mg /12 jam dosis sama untuk CRRT	600 mg/12 jam AD
Metronidazole	6–14	7 21	7.5 mg per kg /6 jam	100%	100% dosis sama untuk CRRT	50%
Nitrofurantoin	0,5	1	50–100 mg	100%	Hindarkan	Hindarkan
Sulfamethoxazole(SMX)	10	20-50	1.0 g /8 jam	/12 jam	/18h Dosis sama	/24 jam

					untuk CAVH	
Trimethoprim(TMP)	11	20-49	100–200 mg /12 jam	/12 jam	>30: /12 jam 10-30: /18 jam dosis sama untuk CRRT	/24 jam
Trimethoprim-sulfamethoxazole-DS						
Terapi (berdasarkan pada TMP)	Sebagai TMP	Sebagai TMP	5–20 mg/kg/hari Terbagi /6-12 jam	5–20 mg/kg/hari terbagi/ 6-12jam	30–50 : 5–7.5 mg/kg /8 jam (dosis sama untuk CRRT) 10–29 : 5–10 mg/kg/12jam	Tidak direkomendasikan, tetapi jika digunakan : 5–10 mg/kg/dosis/24 jam
TMP-SMX Prophylaxis	Sebagai TMP	Sebagai TMP	1 tab po /24jam atau 3x/minggu	100%	100%	100%
Vancomycin	6	1 g /12jam	1 g /12 jam	1 g /24–96jam	1 g/4–7 hari	
Anti tuberculosis						
Ethambutol	4	7 15	15–25 mg/kg/24jam	/24jam	/24–36 jam dosis sama untuk CRRT	/48 jam
Ethionamide	2.1	250–500 mg /12jam	100%	100%	50%	
Isoniazid	0.7–4	8–17	5 mg per kg/hari (max. 300 mg)	100%	100% dosis sama untuk CRRT	100%
Pyrazinamide	9	26	25 mg/kg/24jam (dosis max. 2.5 gm /24jam)	100%	100% dosis sama untuk CRRT	12–25 mg/kg/24 jam
Rifampin	1.5-5	1.8–11	600 mg per hari	600 mg/24jam	300–600 mg/24 Jam dosis sama untuk CRRT	300–600 mg/24jam

6.3 Saat Pemberian Antibiotik

Tabel 5 Saat Pemberian Antibiotik

Nama Generik	AC	DC	PC	Nama Generik	AC	DC	PC
Amoxicillin	+	-	+	Isoniazid	1 jam	-	2 jam
Amoxicillin/ Clavulanic acid	+	+	-	Kanamycin sulfat	+	-	+
Ampicillin	1 jam	-	2 jam	Levofloxacin	+	-	+
Ampicillin / sulbactam	+	-	+	Lincomycin	1 jam	-	2 jam
Azithromycin	1 jam	-	2 jam	Linezolid	+	-	+
Cefadroxil	+	-	+	Metronidazole	-	+	+
Cefixime Cefuroxime	-	+	-	Moxifloxacin Ofloxacin	+	-	+
	-	+	-		+	-	+
Chloramphenicol	1 jam	-	2 jam	Phenoxymethylpenicillin	1 jam	-	2 jam
Ciprofloxacin	+	-	+	Pyrazinamide	-	+	-
Clarithromycin	+	-	+	Rifampicin	1 jam	-	2 jam
Clindamycin	+	-	+	Roxythromycin	+	-	-
Cotrimoxazole	-	+	-	Spiramicin	-	-	+
Doxycycline	-	+	-	Thiamphenicol	1 jam	-	2 jam
Erithromycin	1 jam	-	2 jam				
Ethambutol	-	+	-				

Keterangan :

AC : Ante Coenam (sebelum makan)

DC : Durante Coenam (bersama makan)

PC : Post Coenam (sesudah makan)

Malang, 23 Desember 2025

PLT Direktur Rumah Sakit Prima Husada,



dr. Resti Lestantini, M. Kes
